

POLITICA DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS

**LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA DEBE SER UN PROCESO
PERMANENTE Y PARTICIPATIVO, EN EL QUE TODOS LOS ACTORES
ESTAN LLAMADOS A APORTAR**

SEGUNDA EDICION
Grupo de Trabajo
Política de Salud y Pueblos Indígenas

POR ACUERDO TOMADO EN TALLER NACIONAL REALIZADO EN CONCEPCION LOS DIAS 5 Y 6 DE AGOSTO DE 2004 SE ELIGIO REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS PARA REVISAR DOCUMENTO E INCORPORAR LOS ACUERDOS DEL TALLER.

Integrantes Segunda Edición:

- **Beatriz Painequeo Zona Centro**
- **Alfonso Reiman Zona Sur**
- **Angel Bolaños Zona Norte¹**
- **Daniel Maribur Zona Sur**

Coordinación: Unidad de Salud y Pueblos Indígenas. MINSAL

Edición: Margarita Sáez Salgado

Integrantes Comisión Primera Edición 2003:

- Antrop. Margarita Sáez - Unidad de Salud y Pueblos Indígenas – División de Rectoría y Regulación Sanitaria.
- E.U. Helga Gutierrez - Departamento de Recursos Humanos – División de Planificación Estratégica.
- Dr. Eduardo Medina – Unidad de Medicina Tradicional
División de Rectoría y Regulación Sanitaria.
- Sr. José Miguel Huerta – Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales
- Sra. Mariluz Soto – Departamento de Salud Ambiental – División de Rectoría y Regulación Sanitaria.
- Sra. Claudia Padilla – Unidad de Salud y Pueblos Indígenas División Rectoría y Regulación Sanitaria.
- Antrop. Sergio Pezoa – Unidad de Promoción – División de Rectoría y Regulación Sanitaria.
- Sra. Haydeé Navarrete – Fondo Nacional de Salud.

¹ Durante el período de trabajo de la Comisión, el representante del Norte Don Angel Bolaños, quien era Presidente del Consejo Nacional Aymara en ese momento dejó de pertenecer a la organización, en su reemplazo se incorporó la Consejera Aymara Sra. Cecilia Flores, quien participó de la última reunión de trabajo.

INDICE

CONTENIDO	Pág.
GRUPO DE TRABAJO	3
INDICE	4
AGRADECIMIENTOS	6
PROLOGO	8
INTRODUCCION	10
I PARTE : POLITICA DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS	
PRINCIPIOS Y MARCO CONCEPTUAL	12
1. Consideraciones generales	12
2. Demandas de los pueblos originarios	16
3. La Reforma, objetivos sanitarios y salud de los pueblos originarios	17
4. Un enfoque necesario: equidad e interculturalidad	19
POLITICA DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS EN CHILE	21
Propósito, Objetivos y Ámbitos de Gestión	21
1. Modelo de atención con enfoque intercultural	22
2. Reconocimiento, protección y fortalecimiento de los conocimientos y las prácticas de los sistemas médicos de los pueblos originarios	26
3. Participación social	28
4. Salud Familiar	29
5. Promoción de la Salud	30
6. Aspectos programáticos y de gestión	31
7. Salud Ambiental	32
8. Inversiones e Infraestructura	34
9. Recursos Humanos	35
10. El Fondo Nacional de Salud y los Pueblos Indígenas	39
11. Cooperación y Relaciones Internacionales	41
12. Investigación	42

CONTENIDO	Pág.
II PARTE: MARCO POLITICO Y LEGAL	
a) Antecedentes históricos	45
b) Instrumentos internacionales	46
c) Antecedentes: hitos previos importantes	46
d) Designación del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 1995 - 2004 (Resolución ONU N° 48/163 de 1993)	47
e) El Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. OIT, 1989	48
f) Resolución V OPS/OMS "Salud de los Pueblos Indígenas en las Américas"	51
g) Segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 2005 – 2014	52
h) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.	52
Referencias bibliográficas	54

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a todas las personas que con sus aportes y revisión crítica hicieron posible esta nueva edición del documento de Política de Salud y Pueblos Indígenas. Cabe resaltar que a nivel nacional se realizaron numerosos encuentros, talleres, reuniones donde el documento fue presentado y discutido por diferentes representantes de los pueblos originarios, técnicos y autoridades del sector y otros invitados provenientes del sector académico y organismos no gubernamentales.

Reconocemos el trabajo realizado por los equipos de trabajo del Ministerio de Salud y FONASA en sus distintos niveles, cuya dedicación, creatividad, compromiso y ejemplo, han sido la base para la formulación de esta política. Especialmente agradecemos, el apoyo brindado para crear condiciones a nivel territorial para reunir a diferentes actores en torno a una revisión participativa de la propuesta de política formulada el 2003; y, por el esfuerzo de sistematización de los acuerdos y su envío a la Comisión de Trabajo.

Un gran reconocimiento y particular agradecimiento a los integrantes de la **Comisión de Representantes Indígenas** encargada de la redacción de esta publicación, por la disposición a colaborar en esta compleja tarea, quienes debieron viajar hasta Santiago en numerosas oportunidades para desarrollar un arduo trabajo en un sistema de internado para lograr la meta propuesta: una nueva versión de la política con participación de los pueblos originarios.

Felicitaciones a los integrantes de la Comisión por la tarea realizada, quienes tuvieron que realizar un doble esfuerzo: primero, incorporar las propuestas de los diferentes pueblos originarios a lo largo del territorio nacional; y segundo, formularlas de manera que fuera comprensible para los equipos directivos y técnicos del Sistema de Salud, destinatarios de este documento.

Muchas gracias a todas y todos.

PROLOGO

La Política de Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas anunciada en abril del 2004, nos invita al respeto por nuestra historia, en palabras del Presidente Don Ricardo Lagos Escobar “es el puente que une ambas riberas... nos permite unir el pasado y el futuro, lo que hemos sido y lo que hemos hecho; lo que queremos hacer y a donde queremos llegar”.

Como sector del Estado, salud lleva años de trabajo intentando avanzar en la pertinencia de las Políticas Públicas hacia el mundo indígena, bajo un marco de principios donde se reconoce la diversidad cultural, el derecho a la participación, y los derechos políticos de los indígenas. En este escenario, la Reforma de Salud recoge estos planteamientos y enfatiza la interculturalidad en salud como parte de las grandes tareas a desarrollar en Salud Pública y en la Red Asistencial de Servicios de Salud.

Los cambios paradigmáticos tienen su base en personas, que en un proceso de darse cuenta y de asumir errores, con una reflexión crítica y proactiva se plantean transformar la realidad que afecta a los pueblos originarios. Es así como en 1992, se crea el primer Programa de Salud con Población Mapuche, desarrollado por un grupo de profesionales y autoridades del Servicio de Araucanía de la IX Región.

A partir de 1996 se formula el Programa de Salud y Pueblos Indígenas, el que en sus primeros años cuenta con pequeños recursos económicos, no obstante los equipos técnicos aceptan el desafío y se convierten en pioneros de estos cambios, iniciando un trabajo sistemático con los pueblos originarios y que de manera progresiva ha incrementado sus coberturas a nivel nacional. El trabajo desarrollado no ha estado ausente de dificultades, paso a paso se ha logrado construir confianzas con las comunidades, bajo un marco de respeto y participación. En el camino se han ido venciendo las resistencias y se ha logrado hacer visible lo que antes era invisible, *que no todos los chilenos somos iguales, especialmente si son indígenas*.

Los procesos han dado lugar a numerosos aprendizajes, la mayor fortaleza ha sido los compromisos asumidos tanto de indígenas como de no indígenas, que hoy tiene un grupo humano no menor de personas comprometidas a lo largo del país, que comprende a 22 Servicios de Salud y a las Secretarías Regionales Ministeriales de 10 regiones donde se concentra el mayor porcentaje de población indígena.

La primera edición de la Política difundida el año 2003 se enmarca en recoger la experiencia acumulada y puso el documento a disposición de las comunidades para su revisión, lo que dio lugar a un proceso de consulta nacional, especialmente orientado a los pueblos originarios. Esta segunda edición recoge las distintas visiones y propuestas trabajadas a nivel territorial por representantes de los

pueblos originarios, quienes se han juntado a revisar, discutir y formular recomendaciones para un trabajo que orientará el quehacer del personal de salud.

Reconocemos que aún queda mucho por hacer, el documento que hoy entregamos surge en un momento de gran importancia para la salud pública chilena y se proyecta hacia el futuro. La aplicación real de los principios y objetivos que orientan esta Política de Salud y Pueblos Indígenas, así como su construcción permanente y participativa, constituye un desafío para los equipos directivos y técnicos que concurren en la gestión de salud en todos los niveles, y se enmarca en las líneas orientadoras de la Reforma de la Salud en Chile, que busca construir un Sistema de Salud que responda de mejor manera a las necesidades y expectativas de las personas y colectividades.

DR. PEDRO GARCIA ASPILLAGA
MINISTRO DE SALUD

INTRODUCCION

El presente documento es la expresión de la voluntad del Ministerio de Salud de generar procesos de construcción de políticas públicas con los pueblos indígenas. Es producto del trabajo de diferentes actores, por una parte, de una Comisión Ministerial constituida para el efecto, la que contó con la participación de las diferentes Divisiones del Ministerio, y del Fondo Nacional de Salud, representando el marco de políticas en esta materia para el sector salud en su conjunto, cuyas orientaciones fueron expresadas en la primera edición de la Política el año 2003; y por otra, de un proceso posterior de carácter participativo, en el cual se revisó el documento inicial y se recogieron los aportes de los representantes indígenas de las distintas regiones del país. Finalmente, por acuerdo tomado en reunión nacional realizada en Concepción el año 2004, se constituyó un grupo de representantes indígenas encargado de aprobar e incorporar las propuestas, lo que dio lugar a esta Segunda Edición.

Uno de los fundamentos para una política intercultural en salud es el reconocimiento de que ningún sistema médico es capaz de satisfacer, por sí solo, todas las demandas de salud que presenta una población, lo que implica dejar de concebir el modelo oficial como el único deseable y válido. Sin cuestionar los logros que como Sistema de Salud mostramos orgullosos, es urgente asumir que los pueblos originarios tienen conceptos de salud-enfermedad diferentes y que existen especialistas tradicionales para enfermedades que el sistema de salud oficial nunca sabrá curar, pues no tiene códigos para entender su etiología y por tanto para su rehabilitación, y menos aún para su prevención.

El documento consta de dos partes. La primera constituye el cuerpo de la Política de Salud y Pueblos Indígenas. En ella se establece el marco conceptual que orienta la formulación de la política, así como sus principios, propósito y objetivos específicos y las estrategias a desarrollar en áreas críticas de la gestión sanitaria. El principal desafío que se establece es aportar a la construcción de un modelo de salud pública donde la equidad, la interculturalidad y la participación son los ejes ordenadores, como parte del proceso de reconocimiento y respeto por la diversidad cultural del país.

En la segunda parte y última, se describen los principales antecedentes que permiten contextualizar la formulación de una Política de Salud y Pueblos Indígenas en Chile. En el marco político y legal, se revisan los antecedentes históricos, y los instrumentos internacionales vigentes, tales como la Designación del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, y la Resolución Quinta de la Organización Panamericana de la Salud, más conocida como "Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas en las Américas".

Considerando que la incorporación de un enfoque intercultural en salud pasa por la generación de una nueva forma de entender las relaciones de unos y otros, donde se promueve el acercamiento de mundos culturales distintos, que reconoce la diversidad como un aporte y base de construcción de una nueva Sociedad. Está claro que Salud no puede con todo y que es el Estado en su conjunto, el llamado a producir un gran cambio cultural, no sólo por la necesaria pertinencia de sus políticas hacia los pueblos indígenas sino por lograr una mayor justicia social y reparación histórica.

El documento es una propuesta que apunta a una imagen objetivo, que define un marco conceptual y se pronuncia sobre los objetivos y estrategias que deberán implementarse de acuerdo a cada realidad, no ofrece respuestas puntuales. Los nuevos desafíos se sitúan entonces en continuar trabajando en el diseño de instrumentos específicos, protocolos u otros, que den cuenta en el Modelo de Atención de un enfoque intercultural y que apunten a la disminución de las desigualdades sociales en salud.

Reconocer la validez de los conocimientos y prácticas en salud, desarrollados por los diferentes pueblos originarios a lo largo de su historia y facilitar procesos que se sustenten en el respeto, el entendimiento mutuo y la colaboración, tiene como propósito aportar a mejorar la salud de todos. Eso es lo que hemos llamado “interculturalidad en salud”, mucho más que un nuevo concepto... un paradigma que reconoce la existencia de otros, que interactúan y se enriquecen en esa relación.

I PARTE: POLITICA DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS

PRINCIPIOS Y MARCO CONCEPTUAL

1. Consideraciones generales

En 1993, con la aprobación de la Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas, la Organización Panamericana de la Salud y los Estados Miembros se comprometieron a trabajar con las poblaciones indígenas para mejorar su salud y bienestar, reconociendo el valor del patrimonio cultural y el saber ancestral de los pueblos indígenas y la necesidad de conservarlos. Los principios emanados de la Reunión Hemisférica de Winnipeg² han sido ejes trazadores de muchos procesos en la Región de las Américas: mejorar el acceso a la salud de los pueblos indígenas; reconocer su derecho a controlar sus propios asuntos y desarrollo, entre ellos la salud, siguiendo su marco cultural propio; y a valorar la medicina indígena en sí y por sus aportes a la sociedad mayor, no sólo en el plano académico sino también protegiendo su propiedad intelectual y su patrimonio cultural.

En los últimos años numerosos gobiernos han incorporado líneas de trabajo en materia de salud de los pueblos indígenas. Especialmente, en la última década ha habido una creciente inquietud y muestras de reconocimiento y preocupación por las condiciones de vida y deficiencias en salud que afrontan la mayoría de los pueblos indígenas, donde aún los determinantes sociales han sido insuficientemente estudiados.

La discusión por el reconocimiento sobre la multiculturalidad y la diversidad étnica al interior de los países ha surgido con fuerza en las últimas décadas por parte del movimiento indígena. Igualmente, diversos organismos internacionales se han pronunciado respecto de los derechos de los pueblos originarios.

La realidad de Chile, al igual que en otros países del continente, es pluriétnica, según el último Censo de 2002 el 4.6% de la población se declara perteneciente a alguno de los ocho pueblos originarios, 692.192 personas. En el Censo anterior (1992), el 10.33% de la población mayor de catorce años, 998.385 personas, se autoidentifican como mapuche, aymara o rapa nui. Ambos resultados no son comparables al utilizarse criterios diferentes para la formulación de la pregunta, en el Censo 2002 se homologa la forma de preguntar utilizada en la Encuesta CASEN, lo que permitirá a futuro realizar análisis más integrales. El año 2000 la Encuesta CASEN indica que 666.319 personas pertenecen a alguna de las ocho etnias reconocidas por ley en el país, cifra que se aproxima a la proyección del último Censo.

² I Taller Hemisférico sobre Pueblos Indígenas y Salud, Winnipeg, Canadá, 1993 y ratificado en la Resolución CD37.R5, 1993 de OPS/OMS

En la primera década de gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia nace un proceso de trabajo con los pueblos originarios, que parte con el Acuerdo de Nueva Imperial (1989), inicio de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Durante el gobierno del Presidente Aylwin se formó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) y con ella se formuló la Ley Indígena y se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), institución responsable de velar por el cumplimiento de dicha Ley.

La Ley Indígena (Nº19.253) aprobada en el Congreso en Octubre de 1993, establece que el Estado reconoce “que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos; que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias; y que para ellos la tierra es el fundamento principal de su existencia y cultura”.

El Estado reconoce como principales pueblos indígenas de Chile, Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameño, Quechua, Colla y las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yamana o Yagán de los canales australes. A través de esta ley, el Estado explicita la valoración de su existencia como parte esencial de las raíces de la Nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores. Si bien aún no están reconocidas por Ley, existen comunidades diaguitas organizadas, que mantienen un trabajo con salud.

Respecto de las instituciones del Estado, la Ley Indígena determina en su artículo Nº1 (párrafo 3º) que “es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación”; y en el artículo Nº 34, que “los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce esta ley”.

A partir del año 2000, se crea el Programa Tolerancia y No Discriminación cuyo objetivo central es aportar a la superación de la Discriminación en Chile, a través del diseño de un Plan, que transversalmente aporte al Estado elementos para establecer un nuevo trato con la ciudadanía, en el entendido que ella contempla una diversidad que enriquece la convivencia y la democracia. Con el propósito de “contribuir a la disminución progresiva de las distintas formas de discriminación y a desarrollar un ambiente respetuoso de las diferencias sociales y culturales” se formuló el Plan Nacional para Superar la Discriminación en Chile 2001-2006.

Otra medida gubernamental trascendente fue la creación de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato oficializada por el Presidente Ricardo Lagos a través del

Decreto Supremo N°19 del 18 de enero del año 2001. El Jefe de Estado encomendó a la Comisión la preparación de un informe que diera cuenta de la relación histórica que ha existido entre los Pueblos Indígenas y el Estado, y que permita avanzar hacia un Nuevo Trato entre el Estado, los Pueblos Indígenas y la sociedad chilena toda. El Informe entregado por la Comisión dio origen a la Política de Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas³ presentada en Abril del 2004, donde se formulan un conjunto de propuestas y recomendaciones, entre las que se destacan: “el reconocimiento constitucional es el punto de partida para la ampliación y profundización de los derechos de los pueblos originarios”, “la necesidad de ratificar por parte del Congreso Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, “el mejoramiento de la pertinencia e impacto de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, entre otras.

El trabajo de la Comisión de Nuevo Trato ha permitido reconocer aspectos de la conformación de nuestra sociedad nunca antes develados: “que la identidad, la cultura y la historia de los pueblos indígenas han sido silenciadas tras la conquista y la formación de nuestra república. Y sus consecuencias han sido la reducción territorial, la fragmentación social y la pérdida patrimonial, así como de sus idiomas y tradiciones, llegando incluso a la extinción de pueblos enteros⁴”.

En Salud, la preeminencia del enfoque biomédico y sus avances ha llevado a tratar al individuo sin considerar el respeto a su entorno y a su cultura, situación a la que Chile no se excluye. Las intervenciones se realizan desde una perspectiva que homogeniza a la población y pasa por alto las particularidades de los diferentes pueblos. A esta subordinación se agrega la ausencia de políticas favorables, los procesos de aculturación, la implantación de modelos exógenos de desarrollo y una globalización acelerada de la información.

Recogiendo los llamados de los organismos internacionales, en especial de la Resolución V de OPS/OMS de avanzar desde los Ministerios de Salud en la generación de estrategias nacionales en materia de salud de los pueblos indígenas, los procesos desarrollados a nivel de la IX Región, en el Servicio de Salud Araucanía por el Programa con Población Mapuche iniciado en 1992; y, el mandato de la Ley Indígena de 1993 que señala la responsabilidad del Estado y de sus instituciones en el reconocimiento, respeto y protección de las culturas indígenas; es que comienza a implementarse en nuestro país, a partir de 1996, una línea de trabajo ministerial en esta materia, que deviene en un Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas, dedicado a la generación de orientaciones técnicas y políticas en salud intercultural a nivel nacional.

El Programa tiene por propósito contribuir a mejorar la situación de salud y medio ambiente de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional impulsando el desarrollo de estrategias que aseguren la satisfacción de las necesidades y la

³ Gobierno de Chile. Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. Palacio de la Moneda, 16 de Abril de 2004.

⁴ Op. cit. P. 18.

integralidad de las acciones; considerando sus características culturales, lingüísticas y económicosociales y su participación en la definición y solución de los problemas. En la actualidad, el Programa Especial opera en las Regiones Primera, Segunda, Tercera, Quinta, Octava, Novena, Décima, Undécima, Duodécima y Metropolitana, con la participación de 22 Servicios de Salud en cuyas áreas geográficas tienen mayor concentración de población indígena.

A nivel de Gobierno se crea en el año 2001, el Programa de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas o Programa Orígenes, a través de un Convenio BID/MIDEPLAN, para sectores rurales de comunas de alta concentración de población indígena, en especial, en aquellos territorios que coincidan con las áreas de desarrollo indígena (ADI). Actualmente, se desarrolla la primera fase del Programa en las regiones I, II, VIII, IX y X. Sus componentes son Educación, Salud, Desarrollo Productivo y Fortalecimiento Institucional. El Programa tiene como fin, mejorar las condiciones de vida, a través de un desarrollo integral con identidad y gestión participativa de los pueblos Aymara, Atacameño y Mapuche en el área rural, y fortalecer las instituciones públicas de apoyo a las comunidades y aquellas que les brindan atención para que ésta sea con pertinencia cultural.

El propósito del Programa en su Componente de Salud, es contribuir a que las comunidades indígenas rurales de los pueblos aymara, atacameño y mapuche mejoren su situación de salud mediante la implementación de modelos de salud intercultural co-gestionados con los Servicios de Salud y la puesta en valor de los conocimientos y las prácticas en salud de los pueblos originarios. Los subcomponentes son: 1) Desarrollo de modelos de atención y gestión interculturales 2) Mejoría de calidad, sensibilidad y pertinencia cultural de los servicios de salud en territorio indígena 3) Fortalecimiento de la medicina indígena 4) Mejoría del acceso y capacidad resolutive de la red de servicios interculturales. Estas acciones son complementarias a las que en el ámbito de la salud intercultural viene desarrollando el sector, en el marco del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas.

Igualmente, en el marco de las políticas de modernización del Fondo Nacional de Salud (FONASA), se están llevando a cabo una serie de iniciativas orientadas a mejorar el Seguro Público de Salud, y relevar los derechos de los usuarios. Los programas de Oportunidad de la Atención, Atención Preferente al Adulto Mayor, Firma de compromiso con los beneficiarios, y FONASAmóvil, manifiestan la voluntad de FONASA de mejorar su oferta de servicios a la población.

En lo que respecta a los pueblos originarios, FONASA ha focalizado alguno de estos programas en comunas de alta concentración de población indígena, y ha abierto una línea de mejoría de información a los usuarios indígenas, con el objetivo de dar a conocer el Plan de Salud, que reciban información, se sientan beneficiarios nuestros y reconozcan a FONASA como su asegurador de Salud. La meta nacional

en una primera etapa, fue informar a 10.000 personas de pueblos originarios, asignándose metas a las Direcciones Regionales.

Estos antecedentes constituyen un marco para el desarrollo de políticas gubernamentales en los distintos sectores del Estado. El modo en que las políticas sociales incorporan la diversidad entendida como una forma de reconocimiento del otro, del sujeto, de la comunidad y su cosmovisión, forman parte también del fortalecimiento de los pueblos originarios como actor social con identidad.

2. Demandas de Salud de los Pueblos Indígenas en Chile

Las demandas en materia de salud manifestadas por organizaciones, líderes, autoridades tradicionales y comunidades indígenas a lo largo del país en diferentes instancias de diálogo con organismos de gobierno, y numerosas reuniones y encuentros convocados por salud a nivel local, regional y nacional, se refieren a:

- Demanda por respeto, valoración y preservación de la medicina indígena y del medio ambiente. Por una parte, se plantea la necesidad de resguardar e incentivar el conocimiento indígena, el uso de plantas medicinales y el conocimiento médico de sus sanadores; y por otra, que se diseñen estrategias para proteger los ecosistemas indígenas.
- Demanda por respeto y valoración de la cosmovisión, en un marco integral de la concepción de salud, enfermedad y práctica de los pueblos originarios. Esto significa la consideración de los factores sociales, familiares y medioambientales en la atención.
- Demanda por participación en las decisiones acerca de programas de salud orientados a los pueblos originarios. Es imperativo que el desarrollo de proyectos y programas de salud en comunidades indígenas se base en la promoción de procesos autogestionados, utilización de recursos locales, y participación sistemática y activa de la población en el proceso de planificación, implementación y evaluación de los mismos.
- Demandas de mejoría de la calidad y calidez humana de la atención en los establecimientos de salud y respeto como personas por parte del personal sanitario. Los pueblos originarios describen un trato discriminatorio cuando acuden a hospitales o centros de salud, esta discriminación es doble, pues a la condición indígena se suma la situación de empobrecimiento que han sufrido las comunidades. Respecto de los integrantes de los equipos de salud deben tener conocimiento y valoración de la cultura, lenguaje y medicina indígena. Asimismo, se demanda la participación de las organizaciones indígenas en los procesos de selección del personal que trabajará en cada territorio.

- Demandas de mejoría de la capacidad resolutive de la atención, a nivel de atención primaria y del conjunto de servicios de salud; y en mejoría del acceso a la atención, aumento de frecuencia de rondas rurales, mayor disponibilidad de exámenes médicos y atención de especialidades. Respecto de la organización de servicios hospitalarios, demandan reforzar el rol de los facilitadores interculturales, mayor flexibilidad de los horarios de atención y de visita, acompañamiento de la familia a sus enfermos, ingreso de sanadores ancestrales a las salas de hospitalización; y, consentimiento informado respecto de intervenciones quirúrgicas y realización de autopsias.
- Demanda por participación y control, en el desarrollo de investigaciones con pueblos originarios debe ser bajo el consentimiento y la aprobación; en el desarrollo de proyectos de salud participación de sabios y autoridades de los territorios indígenas.
- Demanda por incorporación del parto tradicional de los pueblos originarios en la atención hospitalaria; incorporar en la certificación de los nacimientos registrar el lugar de residencia de la madre, para su inscripción en el Registro Civil. Además, protección del sistema de alimentación originario, a través de acciones que resguarden los productos vegetales y el medio ambiente en que éstos se desarrollan.
- Demanda de formulación y aplicación de instrumentos de medición de pobreza y desarrollo con parámetros acorde a la realidad cultural y cosmovisión de los pueblos originarios y a que exista una tarjeta que acredite el acceso gratuito al sistema de salud público considerando la aplicación de los parámetros mencionados.

3. La Reforma, los Objetivos Sanitarios y Salud de los Pueblos Indígenas

En el marco legal de la reforma sectorial, la incorporación de la interculturalidad en salud en la Ley de Autoridad Sanitaria, constituye un hito fundamental para la operativización de la Política de Salud y Pueblos Indígenas. En el artículo 16, se establece que es deber del Ministerio de Salud “formular políticas que permitan incorporar un enfoque intercultural en los programas de salud en aquellas comunas con alta concentración indígena”.

A su vez, el Ministerio de Salud en el proceso de reforma sectorial, ha formulado los objetivos sanitarios que orientarán el quehacer del sector público en los próximos años.

La preocupación por la equidad en el acceso, oportunidad, y calidad de la atención, y por disminuir las brechas en la situación de salud de los pueblos indígenas no está ausente del sentido y contenido de dichos objetivos sanitarios, más aún

cuando las evidencias epidemiológicas señalan altos niveles de correlación entre alta concentración de población indígena y mayores grados de riesgo y daño en la salud.

La operacionalización de los objetivos sanitarios aplicados a la realidad de las poblaciones indígenas, debe ser realizada regionalmente, de acuerdo a las particularidades de la situación específica, y en el marco de construcción de procesos participativos con las comunidades y organizaciones indígenas en que se consideren las variables culturales y territoriales involucradas en los problemas sanitarios, en los que se decida la focalización y coordinación de acciones.

Mantener y mejorar los logros sanitarios alcanzados: a nivel nacional, las acciones en el marco de este objetivo se orientarán a mantener y mejorar los logros sanitarios alcanzados en mortalidad infantil y sus componentes, mortalidad materna, morbilidad por enfermedades infecciosas y emergentes, y morbilidad por TBC. En lo referente a los pueblos indígenas, se focalizarán acciones con pertinencia cultural, especialmente en lo relativo a mortalidad infantil, morbilidad por enfermedades infecciosas, salud mental, entre otros. En el ámbito de la situación de salud de los pueblos indígenas, se deben actualizar los diagnósticos, evaluar y mantener las acciones en que se haya conseguido una mejoría sostenida.

Enfrentar los nuevos desafíos derivados del envejecimiento poblacional:

Se establecen en este objetivo, los siguientes macro determinantes: educación, ingreso, etnicidad, género y redes de apoyo. Los factores condicionantes priorizados apuntan a reducir el tabaquismo y la obesidad; a la promoción de una conducta sexual segura; y a reducir los riesgos ambientales. Por otra parte, se espera disminuir la mortalidad por Cardiovasculares, Cánceres, Respiratorias, Diabetes, VIH/SIDA, y Traumatismos. En el ámbito de la morbilidad, se proponen metas en el área de la Salud Mental (Depresión, Trastornos severos y Adicciones), de la Salud Dental (fluoración del agua y aumento de cobertura de atenciones), y de Enfermedades Osteoarticulares (aumentar la cobertura de tratamientos). Será prioritario el contar con información actualizada sobre el perfil epidemiológico y sociodemográfico para establecer prioridades en las intervenciones sanitarias dirigidas a pueblos indígenas.

Reducir las desigualdades en situación de salud y en acceso a la atención de salud:

En relación a la Mortalidad Infantil y Esperanza de Vida, se plantea disminuir la brecha entre grupos educacionales extremos y entre áreas geográficas. En mortalidad infantil, se espera una reducción de brecha de un 10% entre quintiles de ingresos extremos. En cuanto a Años de Vida Potencialmente Perdidos, se plantea continuar con la tendencia de reducción de brecha entre regiones, la que en 1997 era de 20 años, proponiendo su reducción en un 30% en los próximos años. La información disponible muestra mayores desigualdades en situación de salud y acceso a la atención en territorios donde residen los pueblos originarios, el desafío será elaborar estrategias regionales que focalicen las acciones en las comunas con indicadores de mayor vulnerabilidad.

Proveer servicios acordes a las necesidades y expectativas de la población. Para el desarrollo de este objetivo, se formulan metas en materia de protección en salud, acceso, calidad, autorización sanitaria, acreditación de establecimientos y satisfacción usuaria. En relación al acceso, se plantea lograr mayor equidad en la atención de salud a los grupos desprotegidos y pertenecientes a quintiles de menores ingresos, a través de la implementación de un plan garantizado de acceso prestaciones de alta complejidad y de especialistas, con garantía de acceso y oportunidad.

Coherente con los objetivos sanitarios, el Reglamento Orgánico del Ministerio y Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, en su artículo 21, define que “es función del Ministerio de Salud formular políticas que permitan incorporar un enfoque de salud intercultural en los programas de salud en aquellas comunas con alta concentración indígena, permitiendo y favoreciendo la colaboración y complementariedad entre la atención de salud que otorga el Sistema y la que provee la medicina indígena, que permita a esas personas obtener resolución integral y oportuna de sus necesidades de salud en su contexto cultural”.

En la formulación general de la política de salud del Ministerio de Salud, la condición étnica es considerada una de las macro determinantes de la salud en el proceso de planificación y determinación de prioridades sanitarias. Si bien se realiza este reconocimiento, se precisa la necesidad de coordinar acciones con otros sectores sociales del Estado y otros organismos, ya que muchos determinantes no solo responsabilidad del sector salud.

4. Un enfoque necesario: equidad e interculturalidad

Recogiendo los antecedentes expuestos, así como las consideraciones en torno a la equidad y la interculturalidad en salud, es necesario explicitar que el enfoque adoptado en la formulación de la Política de Salud y Pueblos Indígenas en Chile, recoge como puntos centrales estos dos conceptos orientadores.

La equidad apunta a la construcción, a partir de acciones concretas, de un sistema de salud que disminuya efectivamente las brechas de equidad en la situación de salud entre sectores sociales, áreas geográficas y comunas. Ello significa generar acciones en el ámbito de mejoría del acceso, de la calidad, cobertura y efectividad de la atención de salud de los pueblos indígenas.

La interculturalidad apunta a un cambio de actitud y a un cambio cultural en el sistema de salud, que permite abordar la salud desde una perspectiva amplia y establecer otras redes de trabajo para proveer servicios acordes a las necesidades de los pueblos originarios, respetando la diversidad cultural. Ello significa reconocer las particularidades de cada pueblo y territorio, respetar, proteger y

garantizar la pluralidad cultural y la legitimidad del patrimonio cultural de los pueblos originarios.

El enfoque de equidad en salud y pueblos indígenas se sustenta en el reconocimiento de la existencia de mundos socioculturales diversos, donde se encuentran distintas formas de entender y enfrentar el proceso de salud-enfermedad; el sistema médico occidental y la visión holística de los pueblos originarios. El desafío actual es traducir la equidad en acciones específicas: considerar el enfoque intercultural en la organización y provisión de atención en la Red Asistencial de Servicios de Salud.

En materia de acceso y calidad de los servicios de salud, estos deben respetar la integralidad de la cosmovisión y prácticas indígenas, responder a criterios de eficacia y calidez en el alcance de los objetivos en salud, con resultados de satisfacción de la persona, familia y comunidad.

La interculturalidad será entendida como un proceso social interactivo, de reconocimiento, respeto, horizontalidad y colaboración entre dos o más culturas, en un espacio determinado. Interculturalidad significa entonces, la promoción de relaciones de confianza, reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, cooperación y convivencia; y derecho a la diferencia.

El enfoque intercultural en salud releva el reconocimiento y respeto de las singulares y diversas características de cada pueblo originario y pretende crear un ambiente donde estas diferencias puedan coexistir y aportar a la mejoría de la salud de todos, aún cuando se da en un escenario no resuelto de asimetrías de poder, en lo que se refiere a la hegemonía del sistema médico oficial.

La interculturalidad en salud conlleva los siguientes elementos:

- ✓ Integralidad en el concepto de salud-enfermedad.
- ✓ Sistema de salud incluyente, abierto, que reconoce, respeta y aplica concepciones y prácticas de salud de otras culturas.
- ✓ Visión holística.
- ✓ Oferta de servicio regular, equitativa y con pertinencia cultural.
- ✓ Personal de salud calificado y sensible a las necesidades de salud de la población. La capacitación aborda sistemáticamente la diversidad y problemática local en materia de salud.
- ✓ Colaboración entre sistemas médicos oficial e indígena.

Las principales características de las relaciones de interculturalidad son las siguientes: 1) voluntad, 2) reconocimiento mutuo, 3) interacción, 4) aprendizaje mutuo, 5) reciprocidad, 6) horizontalidad y 7) cooperación.

La perspectiva intercultural en salud pone el énfasis en el proceso de encuentro de las diversas culturas que conviven en un territorio, para coordinar acciones y esfuerzos en la solución de problemas comunes.

La aplicación de los conceptos de equidad e interculturalidad, no sólo está relacionada con la salud, sino también con otros aspectos del desarrollo de las personas lo que requiere de esfuerzos multisectoriales en lo social, político y económico.

POLITICA DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS EN CHILE

Propósito y Objetivos

Propósito

Contribuir al mejoramiento de la situación de salud de los pueblos originarios, a través del desarrollo progresivo de un modelo de salud con enfoque intercultural que involucre su activa participación en la construcción, ejecución, control y evaluación del proceso.

Objetivos

1. Avanzar en la construcción participativa de un modelo de salud con enfoque intercultural.
2. Garantizar la participación de los pueblos originarios en la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de estrategias destinadas a mejorar el estado de salud, accesibilidad, calidad y pertinencia de las acciones sanitarias orientadas a la población indígena.
3. Desarrollar en materia de promoción de la salud y enfoque familiar, estrategias que garanticen el fortalecimiento y respeto a la cosmovisión y cultura específica de los pueblos originarios.
4. Incorporar en los establecimientos de la red de servicios de salud, un enfoque intercultural que oriente su quehacer hacia los pueblos originarios y hacia el medio ambiente en que viven.
5. Incorporar los criterios de pertinencia cultural a las inversiones y desarrollo de los modelos médico-arquitectónicos para establecimientos de salud.
6. Contribuir al reconocimiento, protección y desarrollo de los conocimientos y las prácticas ancestrales en salud de los pueblos originarios.
7. Mejorar la calidad y pertinencia cultural de las acciones de salud, a través de estrategias de formación, perfeccionamiento y desarrollo de recursos humanos.
8. Favorecer la participación de los pueblos originarios en las estrategias desarrolladas por FONASA para mejorar el Seguro Público de salud.
9. Generar programas de recuperación y protección del medio ambiente con pertinencia cultural y participación de los pueblos originarios, que involucre recursos económicos y humanos.

10. Acrecentar la coordinación de acciones intra e intersectoriales orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida y salud de los pueblos originarios.

Estrategia: apoyar la formulación, financiamiento e implementación de programas, planes y actividades, que permitan el desarrollo de los objetivos.

Los ejes de la Política son tres: Equidad, Interculturalidad y Participación y su desarrollo debe ser transversal en los distintos ámbitos de gestión en salud pública. Los siguientes lineamientos técnicos son ejemplos donde estos deben reflejarse:

1. Modelo de Atención con Enfoque Intercultural

En la propuesta de trabajo Ministerial "Hacia un Nuevo Modelo de Gestión en Salud"⁵ se definen los elementos del nuevo modelo de gestión: "la comprensión de la salud como un bien social común; la necesidad de hacer arreglos sociales para la protección financiera equitativa y solidaria de todas las personas; la necesidad de priorizar el fomento y la prevención; de comprometer a la sociedad en su conjunto, más allá del sistema de atención, en la implementación de políticas saludables; de acercar la salud a las personas al dar énfasis a la ambulatorización de la atención en una comprensión biopsicosocial de ésta, enfrentando a la persona en su contexto familiar y comunitario; en la búsqueda de co-responsabilizar a las personas y a la comunidad en la implementación y control de las políticas y estrategias....".

Uno de los fundamentos para una política intercultural en salud es el reconocimiento de que ningún sistema médico es capaz de satisfacer, por sí solo, todas las demandas de salud que presenta una población, lo que implica dejar de concebir el modelo occidental como el único deseable y válido. La medicina indígena es integral y tiene un ancestral, amplio y dinámico desarrollo.

En este marco, la construcción de un modelo de atención acorde a las necesidades y características culturales de la población indígena en Chile es un desafío y un proceso en desarrollo, que se enmarca en el cambio del modelo de atención, en el que se reconocen distintas etapas, desde el enfoque bio-médico, a uno biopsicosocial y finalmente, a uno más integral, que incluya aspectos culturales, espirituales, religiosos y ambientales.

Un modelo de atención con enfoque intercultural debe incorporar la pertinencia cultural de los servicios, la que se entiende como la adecuación de los servicios a las características de la cultura, basada en el respeto y en la construcción colectiva de estrategias, metodologías y protocolos que mejoren el acceso, la oportunidad y efectividad de los servicios de salud. Lo anterior debe expresarse tanto en la

⁵ Contenidos del Proyecto de Ley de Autoridad Sanitaria y Gestión en Salud y de Medidas Administrativas Inmediatas, Ministerio de Salud.

organización y en la provisión de los servicios, desarrollando iniciativas innovadoras que pueden abarcar desde formular una norma (por ejemplo, protocolo de atención), a la organización de horarios de atención adecuados a las necesidades de las comunidades, señalética apropiada culturalmente, entre otras.

La interculturalidad en salud requiere del desarrollo de procesos donde los propios pueblos originarios expresan la voluntad de encontrarse en una relación horizontal con la salud occidental. Los pueblos originarios han desarrollado un conjunto de conocimientos y prácticas en salud donde conciben la realidad como un todo integrado, donde el hombre es un elemento de la naturaleza y donde el orden está fuera de la voluntad humana. Su cosmovisión se basa en el equilibrio, la armonía y la integralidad, donde está presente la convivencia con los demás seres humanos, con la naturaleza y con los seres espirituales. Los terapeutas tradicionales indígenas reciben nombres de acuerdo con su especialidad, y varían de pueblo a pueblo: machi, lawentuchefe, kolliri, yatiri, yacho, médica, partera y componedor, entre otros ; y coexisten en nuestro país como expresión viva de conocimientos y prácticas en las comunidades indígenas.

Un principio rector en que se puede manifestar la interculturalidad en salud, es la complementariedad de sistemas médicos, lo que no constituye una relación obligada. Se propone un acercamiento del equipo de salud con los especialistas de la medicina indígena, que permita derivar e intercambiar conocimientos cuando se estime necesario, por ejemplo a través del estudio de casos. Este cambio de actitud de los equipos técnicos debe basarse en el respeto por los conocimientos del otro y la generación de espacios de confianza que den lugar a la complementariedad entre ambas medicinas, donde cada uno mantiene sus conocimientos en salud y se enriquece en el intercambio.

A su vez, el modelo de atención debe incorporar estrategias para mejorar la accesibilidad, la calidad de la atención de salud, la resolutivez de los problemas de salud de la población indígena y fortalecer acciones de promoción de la salud; incorporando en los planes, programas y proyectos institucionales acciones orientadas a disminuir las brechas de equidad observadas en la situación de salud. En este proceso se deberá garantizar la participación de los pueblos indígenas en los planes, ejecución y evaluación de las actividades.

La integralidad para los pueblos originarios es parte de su cosmovisión, donde existe ciencia y sabiduría ancestral. En esta visión holística, el concepto de territorio, las dimensiones colectivas de la salud y la protección de los sitios sagrados constituyen elementos fundamentales para recuperar, preservar la salud y prevenir la enfermedad.

Los principios que deben orientar este cambio en el modelo de atención son:

- **Integralidad:** Orientar las acciones a la atención continua e integral de la persona, considerando los aspectos de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Desde una concepción amplia se debe abarcar al individuo, familia, comunidad incluyendo dimensiones físicas, psicológicas, espirituales, culturales, sociales y ambientales.
- **Calidad:** una atención de calidad no sólo proporciona servicios profesionales y humanos óptimos sino también comprende la pertinencia cultural en el trabajo sanitario, el respeto de los valores y conocimientos de los pueblos originarios; sin descuidar la oportunidad y efectividad de las acciones y la satisfacción de los usuarios.
- **Equidad en el acceso:** la atención de la salud debe priorizar a los grupos en riesgo, eliminando las barreras económicas, geográficas, culturales y/o de organización del sistema de atención.
- **Complementariedad:** la atención de salud debe favorecer el respeto a la diversidad y la voluntad de colaboración entre los sistemas médicos de medicina oficial e indígena.
- **Participación:** derecho a la participación sistemática. Este modelo de atención debe ser construido desde la participación de la población y organizaciones indígenas, en todas las etapas de la planificación local en salud, y en todas sus dimensiones: prevención, promoción, rehabilitación y recuperación.
- **Enfoque de género:** la construcción de un modelo de salud con enfoque intercultural no debe soslayar la mirada de género, en el sentido de poder diferenciar la situación de salud, necesidades y rol de las mujeres y de los hombres indígenas en el fenómeno de salud y enfermedad de las comunidades⁶. Especial relevancia debiera tener el rol de las familias indígenas en la transmisión de la cultura y las prácticas de salud y prevención de la enfermedad.

Estrategias:

- ✓ Planificar, ejecutar y evaluar en conjunto con las comunidades y organizaciones indígenas, experiencias de modelos de atención con enfoque intercultural.
- ✓ Formular protocolos⁷ de atención con enfoque intercultural.

⁶ Desde la visión de los pueblos originarios respecto al enfoque de género las diferencias no implican desigualdad, sino complementariedad, reciprocidad y dualidad.

⁷ Protocolo de atención es un instrumento que determina el tipo y complejidad de las enfermedades que se atienden en los diferentes establecimientos de salud, donde se definen los procedimientos mínimos que se

- ✓ Establecer estándares de calidad de atención con enfoque intercultural que permitan la acreditación de las acciones.
- ✓ Desarrollar procesos orientados a la implementación gradual de sistemas de salud articulados (sistemas indígenas y occidentales), con experiencias sistematizadas, documentadas y publicadas.
- ✓ Favorecer que los facilitadores interculturales formen parte de un equipo multidisciplinario, que participen de los procesos de programación, ejecución y evaluación en cada establecimiento.
- ✓ Promover que las rondas médicas rurales de comunas con alta concentración de población indígena trabajen con especialistas en medicina indígena de esos territorios.

En los establecimientos de salud con enfoque intercultural, podrán observarse los siguientes signos de cambio:

- Diagnóstico de situación de salud con enfoque sociocultural, incluye conocimiento de los recursos de salud oficiales e indígenas.
- Líderes y profesionales indígenas comprometidos participan en el diseño, gestión, evaluación y control del modelo de atención.
- El equipo de salud respeta los diagnósticos de los especialistas en medicina ancestral y articula procedimientos de referencia y contrareferencia de usuarios.
- El establecimiento facilita el acceso a los agentes de medicina indígena cuando los usuarios lo solicitan.
- Existe señalética apropiada según territorio.
- Los horarios de atención responden a la realidad y necesidades de las comunidades.
- Existe incorporación de herbolaria medicinal ancestral y otros recursos terapéuticos locales.
- Existe hospedaje o albergue para familiares de los enfermos hospitalizados.
- Existe adecuación de horario de visitas a enfermo hospitalizado.
- La arquitectura es culturalmente adecuada a la cosmovisión indígena y el mobiliario local es pertinente a la cultura.

deben realizar, el tipo de recurso humano requerido, los exámenes y procedimientos necesarios con relación a la enfermedad y de acuerdo al nivel de complejidad.

- La capacitación en interculturalidad es obligatoria para el personal de salud del establecimiento.
- La alimentación es culturalmente adecuada y de acuerdo a la tradición indígena.
- Se ofrece la alternativa de atención del parto respetando procedimientos ancestrales.
- Existencia de un documento que describe los conceptos de salud-enfermedad, síntomas y signos reconocidos por la medicina indígena y su posible relación o no relación con la medicina occidental.

2. Reconocimiento, protección y fortalecimiento de los conocimientos y las prácticas de los sistemas médicos de los pueblos originarios.

Sistemas médicos de los pueblos originarios, se entenderán como un conjunto de conocimientos, prácticas, tecnologías y especialistas fundamentados en la sabiduría ancestral y comunitaria, organizados sobre una particular cosmovisión del mundo y legitimados por sus propias comunidades.

Los conocimientos y prácticas de las comunidades indígenas en salud constituyen parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, y su protección y reconocimiento han estado presentes en las demandas tanto sectoriales como generales que se han formulado en las distintas instancias de diálogo con el Estado.

La construcción del modelo de interculturalidad en salud constituye un espacio de trabajo conjunto entre el sistema de salud oficial y sistema de salud indígena, proceso en que se busca la construcción de relaciones de confianza entre ambos sistemas médicos. El reconocimiento de la medicina indígena forma parte de la deuda histórica que la sociedad chilena tiene con los pueblos originarios, en cuanto a valorar el aporte que realizan a partir de su propia cosmovisión, conocimientos, valores y prácticas de la vida y la salud. Sin embargo, este por sí solo no es suficiente para avanzar en la demanda más amplia por reconocimiento, que debe ser constitucional

En este contexto, la tarea de contribuir al reconocimiento, protección y fortalecimiento de la medicina indígena, en tanto sistema de conocimientos y prácticas sobre la salud y la enfermedad. Como parte del patrimonio cultural debe ser abordado como un desafío que no involucra sólo al sector salud, debe ser intersectorial.

Con respecto a las tareas específicas de salud en la materia, se propone avanzar en el desarrollo de experiencias locales de colaboración entre sistemas médicos, en la red de servicios del sistema.

Para ello serán tareas prioritarias:

Favorecer la protección de los conocimientos tradicionales en salud de la posible utilización con otros fines, como también la diversidad biológica y los derechos de propiedad intelectual de los pueblos originarios, para que no sean plagiados o patentados por personas naturales o jurídicas foráneas a las comunidades.

Implementar un trabajo intersectorial que haga efectivas las recomendaciones del Convenio de Diversidad Biológica, en lo referente a los conocimientos, prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas en materia de biodiversidad ⁸. Esto involucra la necesidad de establecer una línea de trabajo intersectorial con CONAF, CONAMA, CONADI y otros organismos pertinentes para hacer efectivas las medidas propuestas por el convenio.

Favorecer líneas de investigación respecto a la medicina indígena, con participación de las propias comunidades, orientadas a identificar la eficacia, seguridad y costo efectividad de terapias o prácticas específicas; estrategias de preservación de los recursos terapéuticos y formas de reproducción cultural de la medicina indígena, y otros temas de investigación que sean priorizados con las comunidades.

Asimismo, avanzar en la construcción de una política respecto a las medicinas indígenas, que reconozca y valide el uso y transporte de las plantas medicinales de la medicina ancestral. Dicha política deberá resultar de un proceso de negociación entre los diferentes sectores involucrados y los pueblos originarios.

Estrategias:

- ✓ Valorar y respetar a los distintos especialistas en salud ancestral.
- ✓ Favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre especialistas en salud ancestral y sus comunidades.
- ✓ Facilitar iniciativas de fortalecimiento de los sistemas de salud ancestral.
- ✓ Revisar y modificar el Código Sanitario en función del reconocimiento a los sistemas médicos originarios⁹.

⁸ El Convenio establece, en el artículo 8 j), lo siguiente: Con arreglo a su legislación nacional, se respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.

⁹ En el Código Sanitario se establece que sólo podrán desempeñar actividades propias de la medicina, odontología, química y farmacia u otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud, quienes posean el título respectivo otorgado por la Universidad de Chile u otra Universidad reconocida por el Estado y estén habilitados legalmente para sus profesiones. Libro Quinto.

- ✓ Favorecer el desarrollo de centros de salud en que se complemente la medicina oficial con la medicina ancestral y en que se fortalezca la autogestión de las comunidades y organizaciones indígenas en dichos procesos.

3. Participación Social

La participación social es un concepto que se refiere a los procesos sociales a través de los cuales los grupos (incluida la comunidad), las organizaciones, las instituciones, los sectores – todos los actores sociales a todos los niveles dentro de una zona geográfica determinada-intervienen de manera informada en la identificación de las cuestiones de salud u otros problemas afines y se unen en una alianza para diseñar, probar y poner en práctica las soluciones¹⁰.

El proceso de participación social reconoce que las medidas sobre salud a nivel local serán resultado de una alianza que se negocia continuamente a medida que van cambiando las condiciones.

La participación social se considera no sólo como un medio para ofrecer servicios de atención de salud más efectivos, sino como un fin y un indicador de democracia y derechos políticos.

Bajo el principio de respeto a la diversidad¹¹, la diferencia debe ser considerada un valor y no un motivo de exclusión o división en la construcción de una sociedad basada en la tolerancia y el respeto, por lo que será necesario reforzar la incorporación activa de los pueblos originarios en el desarrollo de las políticas, los planes y los programas de salud.

La participación indígena es un requisito indispensable para el desarrollo de programas y planes locales y regionales, no limitándola a las etapas de diagnóstico y levantamiento de necesidades. Se debe considerar la participación de los pueblos originarios en la gestión, control y evaluación de programas de trabajo, avanzando con ello en el afianzamiento de su reconocimiento y valoración de su aporte a la construcción de la salud como un bien colectivo.

¹⁰ Definición de OPS/OMS citada por Marsall M. T.; Sáez, M. y Salinas, J. "Participación en Salud: Lecciones y Desafíos". CORSAPS, Santiago, Chile, Mayo, 1991.

¹¹ *Diversidad*. Significa reconocer las particularidades de cada pueblo y territorio, respetar, proteger y garantizar la pluralidad cultural y la legitimidad del patrimonio cultural de los pueblos originarios.

Estrategias:

Fomentar la constitución de contrapartes técnicas de los pueblos originarios a nivel comunal, provincial, regional y nacional; encargados de recomendar, planificar, monitorear y evaluar las políticas, planes y programas en salud.

Generar mecanismos para la manutención y ampliación de espacios de participación de los pueblos indígenas en las distintas instancias de la estructura del sistema de salud, respetando sus protocolos y reconociendo sus autoridades para:

- Definir Políticas de Salud y Pueblos Indígenas
- Definir estrategias y actividades en torno a reconocimiento de la medicina indígena y fortalecimiento de la cultura.
- Definir Planes de Salud y Pueblos Indígenas en Servicios de Salud.
- Definir distribución de recursos y evaluación de proyectos.

4. Salud Familiar

El Modelo de Atención con Enfoque Integral y Familiar, “se orienta a la mejoría de la calidad de vida de las personas, las familias y las comunidades, es uno de los pilares fundamentales para el logro del objetivo de la reforma del sector. Este desafío sectorial obliga a relevar la Atención Primaria, que es la que en mayor medida recoge y contribuye al cambio cultural y de modelo asistencial que se requiere”¹².

El Modelo de Salud Familiar apunta a la resolución de los grandes desafíos de la atención primaria de salud¹³:

- ✓ Lograr el equilibrio entre la necesidad de acercar la atención a la población beneficiaria, aumentar la satisfacción del usuario, mejorar la capacidad resolutive y controlar los costos de operación del sistema simultáneamente, sin privilegiar un factor en desmedro de los otros.
- ✓ Alcanzar un aumento porcentual creciente de las acciones de promoción y prevención, sin que se produzca deterioro en la resolución oportuna y eficiente de la demanda por morbilidad.
- ✓ Favorecer, mediante sistemas eficientes y efectivos de participación, que el usuario y la comunidad asuman un rol activo como agentes de cambio de su propia situación de salud.

En este marco, el rol de las familias y comunidades debe ser proactivo, donde “se considera que apoyando a la familia y a cada uno de sus integrantes en el desarrollo de habilidades y destrezas para una vida saludable, está actuando sobre

¹² Documento: Modelo de Atención con Enfoque Familiar en el Nivel Primario. Depto. Atención Primaria. Ministerio de Salud

¹³ Documento: Atención de Salud con enfoque Familiar. Depto. Atención Primaria. Ministerio de Salud.

el núcleo principal de la sociedad, aquel que le proporciona a la persona el sustento básico que necesita para ir construyendo sus valores de tolerancia y de respeto que le permitirán hacerse parte de un proyecto común. Y eso es precisamente lo que el sector salud quiere entregar como aporte a una cultura de la tolerancia, más allá de su compromiso ineludible con el cuidado de la salud de las personas”¹⁴.

El modelo de atención con enfoque de interculturalidad en salud no está separado de los procesos de cambio que a nivel de atención primaria se promueven. La salud familiar en nuestro país es hoy uno de las apuestas fundamentales para trabajar integralmente con las familias y comunidades indígenas, la vinculación de ambos procesos a nivel local permitirá avanzar progresivamente en la transformación del sistema de salud.

Un modelo de atención con enfoque familiar, colectivo e intercultural debe incorporar estrategias que respondan a las especificidades de los pueblos originarios en las políticas de atención, prevención, rehabilitación y promoción de la salud, que sean diseñadas, ejecutadas y evaluadas con participación. Para ello, es fundamental promover un proceso de sensibilización y capacitación del personal de salud para que se respeten las especificidades culturales y proporcionen una atención de salud incluyente e integral. Bajo este enfoque, la pertinencia cultural de las acciones en salud se constituye en un desafío insoslayable.

La estrategia debe ser incorporar en el modelo de atención de los Centros de Salud Familiar, la pertinencia cultural de las acciones preventivas, recuperativas y de promoción de la salud.

5. Promoción de la Salud

La promoción de la salud es concebida como “una estrategia que involucra a individuos, familias, comunidades y sociedad en un proceso de cambio orientado a la modificación de las condicionantes de la salud y mejoramiento de la calidad de vida”, con el propósito de optimizar la salud y reducir las determinantes de la enfermedad.¹⁵

La promoción es una perspectiva de salud positiva y de bienestar, que se complementa con las acciones de prevención de la enfermedad, en una relación sinérgica que tiene como propósito maximizar la salud y el bienestar.

Las acciones de promoción a través de Planes Regionales y Comunales de Promoción de la Salud se orientan a: promover estilos de vida y ambientes saludables; a aumentar el conocimiento y capacidades individuales y comunitarias

¹⁴ Op. cit

¹⁵ Ministerio de Salud. División de Atención Primaria. Unidad de Promoción de la Salud. “Promoción de la Salud para Chile. Plan Nacional de Promoción de la Salud”. Santiago, 1999

para cuidar la salud; y a reforzar el rol regulador del Estado sobre las condicionantes de salud. Estos planes, son el instrumento a través del cual se puede lograr una integración conceptual y práctica entre el enfoque promocional, y el enfoque de interculturalidad y equidad del trabajo en salud con población indígena.

Uno de los fundamentos de la práctica de la Promoción es “reconocer con acciones concretas, que las personas, familias y comunidades constituyen la principal fuente de salud”.¹⁶

Concordante con lo anterior, la promoción estimula la participación buscando el fortalecimiento de una “comunidad consciente y responsable..., que es aquella capaz de identificar sus problemas, necesidades y demandas, de reflexionar sobre los problemas que la atañen y que reconoce su capacidad para actuar sobre ella buscando soluciones. En el marco de la promoción de la salud, es una comunidad que identifica los condicionantes de su salud y calidad de vida, y que es capaz de proponer soluciones y movilizar recursos, tanto materiales como humanos.”¹⁷

Dentro de este marco, las acciones de promoción de la salud con y desde la población indígena deben considerar los estilos de vida, cosmovisión y valores culturales, y evaluar la pertinencia de la aplicación de las estrategias de promoción de la salud en las comunidades indígenas.

La propuesta es incorporar el enfoque intercultural en los programas de promoción: el reconocimiento del aporte de la cosmovisión indígena a la construcción de acciones de promoción, que recoja el conocimiento y difusión de los factores protectores y estilos de vida saludables, constituye un sólido aporte al desarrollo de la promoción de la salud a nivel local.

6. Aspectos programáticos y de gestión

Las actuales orientaciones programáticas ministeriales consideran aperturas según edad, sexo y origen rural/urbano.

La identidad indígena nunca ha sido registrada directamente en las estadísticas del sector, cuando se ha asociado con algunos fenómenos de salud, ha debido ser inferida indirectamente según apellidos indígenas, realizando estimaciones demográficas en áreas con alta proporción de población con estas características, entre otras. Constituye por lo tanto, un desafío avanzar en la consideración de la variable dentro de las orientaciones programáticas, en aquellos Servicios de Salud, comunas y establecimientos con alta concentración de población indígena y en la

¹⁶ Ministerio de Salud, “Plan Nacional de Promoción de la Salud” 1998 – 2000.

¹⁷ Ministerio de Salud – División de Salud de las Personas “Marco de referencia para la acción regional en Promoción de Salud” . Documento de Trabajo, mayo, 1997.

adecuación los diferentes programas de salud a la cosmovisión propia de los pueblos originarios.

La incorporación de esta variable en los planes de salud comunal es una herramienta que permitirá la adecuación y pertinencia de las estrategias y actividades a nivel local a las necesidades de los pueblos indígenas.

Estrategias

- ✓ Avanzar en la creación de condiciones para la incorporación de la variable identidad indígena a los sistemas de registros estadísticos de salud, en el marco del desarrollo y validación de experiencias locales. Esto, será en concordancia con los registros que desde otros sectores del ámbito público se realizan, como por ejemplo, herramientas como el Censo de población, la Encuesta Casen, los registros de la CONADI, u otros.
- ✓ Incorporar el enfoque intercultural en la provisión servicios de salud. Requiere del análisis de los diferentes objetivos técnicos, identificando elementos que puedan incluir un enfoque intercultural, por ejemplo, en el área de nutrición, del Niño (desarrollo psicomotor), de la Mujer, de Salud Mental, entre otros. El desafío es producir nuevos instrumentos y normas en un proceso que involucre a cada uno de los niveles (nivel local, regional, Servicios de Salud, nivel central) y comprometer a los directivos en la transversalidad interna.
- ✓ Incorporar el enfoque intercultural en los planes comunales de salud; contar con un diagnóstico participativo que entregue elementos de base para incorporar el enfoque intercultural en la programación local.
- ✓ Implementar estrategias que permitan avanzar en el desarrollo de la Epidemiología con enfoque sociocultural.
- ✓ Fortalecer el desarrollo de iniciativas innovadoras por ejemplo, facilitadores interculturales, asesores culturales, diversificar la atención profesional del parto, sistemas de referencia y contrareferencia entre sistemas médicos, entre otras.
- ✓ Crear áreas de demostración urbanas y rurales por ejemplo, fijar estándares de acreditación de hospitales, consultorios y postas rurales como establecimientos interculturales, diferenciar pautas de evaluación de establecimientos con esta orientación, entre otros.

7. Salud Ambiental

Las comunidades indígenas rurales y el mundo rural en general se han visto afectada en su calidad de vida debido a la alteración de los ecosistemas y entornos originarios, y a la expansión de actividades económicas productivas en los territorios que afectan su desenvolvimiento y cosmovisión. En efecto, para los pueblos originarios existe una concepción holística del fenómeno salud - enfermedad, la salud es un concepto

integral, por lo que el tema del medio ambiente no debe ser tratado por separado en las políticas a desarrollar.

Para poder formular una política de trabajo en salud del medioambiente es necesario conocer cual es la percepción de la comunidad frente al tema, además rescatar los conocimientos originarios que existen, para así elaborar una propuesta de trabajo conjunta entre servicios o equipos de salud y comunidades, que incorpore los conocimientos ancestrales y originarios en esta materia.

Consecuentemente, se debe favorecer la participación indígena en la generación de planes y proyectos de salud ambiental.

La formulación de una política en el ámbito de la salud ambiental y los pueblos indígenas debe estar orientada a contribuir a la disminución del riesgo de transmisión de enfermedades provocadas por factores ambientales, particularmente los relacionados con el acceso y calidad del agua, las condiciones de saneamiento inadecuado y por el deterioro medioambiental de los territorios.

Se deben priorizar las acciones de identificación de comunas, comunidades y sectores de mayor riesgo, favoreciendo el trabajo intersectorial de la búsqueda de soluciones a las situaciones específicas, y se debe potenciar el trabajo con las organizaciones indígenas para planificar, ejecutar y evaluar las acciones, con enfoques de participación comunitaria y de tecnologías apropiadas.

Se requiere incorporar el enfoque de los pueblos indígenas en la Salud Ambiental. Esto significa recoger la visión que los pueblos originarios tienen sobre el medioambiente y los problemas que se presentan. La introducción de nuevas tecnologías para la protección y manejo sustentable del medio ambiente, debe realizarse con el consentimiento y la aprobación de los pueblos originarios en sus territorios, velando por que estas no transgredan la visión propia que tienen sobre estos problemas.

Estrategias

- ✓ Planificar soluciones a problemas ambientales urgentes con los pueblos originarios, involucrándolos en la creación de políticas, programas, planes y proyectos medioambientales en los distintos territorios. Propiciar el trabajo intersectorial.
- ✓ Complementar los conocimientos tecnológicos occidentales e indígenas para la elaboración de un nuevo conocimiento que ayude a solucionar los problemas ambientales dentro de una concepción holística, integral y de derecho de los pueblos originarios.
- ✓ Elaborar criterios para una propuesta de atención primaria ambiental con participación de los pueblos originarios, basada en los principios de equidad, participación y respeto a su cosmovisión.

- ✓ Fomentar la protección y recuperación del patrimonio medicinal y sitios sagrados en territorios de los pueblos originarios, en coordinación y cooperación con otros sectores e instituciones del Estado.
- ✓ Realizar investigaciones sobre la actual situación medioambiental en todos los territorios indígenas, para conocer las diversas agresiones medioambientales que afectan hoy a estas comunidades y su impacto en la salud de las personas, donde los temas de investigación se definan en las comunidades, se acuerden medidas preventivas y se supervise su cumplimiento.
- ✓ Incorporar el enfoque intercultural a las labores que desempeñan las Unidades de Epidemiología, de modo que se vigile desde la visión indígena y occidental la situación medio ambiental en los aspectos de mayor relevancia, como: efectos del uso de plaguicidas, fertilizantes; introducción de productos transgénicos: efectos de la contaminación de aguas, tierras, subsuelos, aire, ruidos, tala irracional de la vegetación, entre otros. Incorporar la visión de sabios y especialistas indígenas en la materia.
- ✓ Capacitar a las distintas unidades de medio ambiente, en cosmovisión y cultura indígena, tecnologías de protección y fomento de la calidad ambiental con pertinencia cultural, tecnologías apropiadas para ser compartidas con la comunidad y su posterior aplicación.

8. Inversiones e Infraestructura.

La construcción y mejoramiento de establecimientos de salud en comunas de alta concentración de población indígena constituye un área de interés en el que debiera considerarse la incorporación de aspectos culturales particulares de la población.

Modelos médico – arquitectónicos de establecimientos de salud en comunas con alta concentración de población indígena

En virtud de lo anterior, se requiere la incorporación de los siguientes elementos a los marcos normativos de inversiones públicas en salud en comunas de alta concentración de población indígena:

- ✓ Incorporar la participación de los usuarios indígenas a nivel comunitario, en la etapa de identificación y priorización, pre inversión y etapas de diseño.
- ✓ La adecuación de infraestructura a las prácticas culturales de manejo de enfermos: consideración de espacios de atención para agentes de medicina tradicional intra establecimiento, inclusión de espacios ceremoniales exteriores y espacios para cultivo de plantas medicinales.
- ✓ Considerar elementos de orientación y luminosidad acordes a cosmovisión indígena del área involucrada.
- ✓ Señalética adecuada interculturalmente.

- ✓ Considerar espacios de acogida para la familia, en el mismo sentido que tienen las Casas de la Madre Campesina: sitios de albergue, espacio para el cuidado de niños preescolares, entre otros.

9. Recursos Humanos

Antecedentes

El desarrollo de Recursos Humanos constituye uno de los ejes prioritarios de los planes nacionales de salud. Se entiende como una estrategia básica en el desarrollo de los sistemas y servicios de salud.

Dado lo anterior y teniendo en cuenta, los distintos pueblos originarios existentes en nuestro país es fundamental la incorporación de un enfoque intercultural en los programas de formación, capacitación y desarrollo de los recursos humanos. Es el recurso humano con sus conocimientos, habilidades y destrezas el que permitirá avanzar en la implementación del nuevo modelo de atención, para ello se requiere que el personal de salud tenga la oportunidad de capacitarse, como asimismo, que las nuevas generaciones de egresados de las universidades e institutos de formación técnica hayan sido preparadas para asumir sus nuevos roles.

Junto a las dificultades de acceso a salud de algunas comunidades por razones geográficas, existe un desconocimiento del personal de salud, en relación a la cultura de las comunidades indígenas, y práctica de la medicina tradicional indígena, lo que hace aumentar los problemas de acceso y calidad de la atención. Frente a las barreras culturales en el acceso, se debe contar con un recurso humano calificado, sensible y respetuoso a la diversidad cultural y de las necesidades de los usuarios.

La capacitación de todo el personal de salud debe considerar tanto a aquellos que se desempeñan en comunas con alta concentración de población indígena como a los funcionarios del nivel central. Para lo cual será necesario desarrollar procesos de educación permanente, que desarrolle destrezas en pertinencia cultural en la provisión de servicios y donde debe abordarse sistemáticamente la cultura y problemática local en materia de salud.

Estrategias

- ✓ Constituir en todos los Servicios de Salud que cuenten en su jurisdicción con población indígena, un equipo multiprofesional integrado por indígenas y no indígenas, con funciones exclusivas en el trabajo con pueblos originarios y que realice funciones de asesoría técnica, planificación, coordinación y evaluación de las acciones. Los miembros de estos equipos deben asumir funciones en el ámbito de la capacitación al personal de salud y difusión de los programas y trabajo realizado a toda la comunidad.
- ✓ Generar acciones orientadas a la formación y desarrollo del recurso humano del sector salud en el enfoque intercultural, permitiendo que se constituya en un

agente eficaz para la mejoría de la situación de salud de las comunidades indígenas y para abordar en forma apropiada las demandas de salud de los pueblos originarios.

- ✓ Contar con equipos de salud suficientes para cubrir las necesidades básicas de atención de la población indígena, con capacitación permanente en el tema.
- ✓ Favorecer la incorporación de profesionales y técnicos provenientes de los pueblos originarios, que además actúen como facilitadores interculturales en los equipos de salud de territorios en los que exista población indígena.
- ✓ Permitir espacios que posibiliten la presencia de agentes de la comunidad (monitores, promotores), participando en la programación, ejecución y evaluación de las acciones de salud, a nivel de la Atención Primaria.
- ✓ Asegurar a través del ciclo de destinación, una mayor permanencia de los médicos generales de zona que trabajan en sectores rurales y comunas con población indígena, previa evaluación y solicitud de la comunidad.
- ✓ Generar instancias de trabajo con Servicios de Salud, Centros Universitarios y Centros de Formación Técnica con experiencia en la materia, e integrando a organismos responsables del tema como la CONADI, para contar con recurso humano formado desde el pregrado en interculturalidad.
- ✓ Fortalecer el Programa de Ciclo de Destinación de Profesionales, en lo que se refiere a la distribución del recurso humano en los Servicios de Salud con población indígena y sus profesionales deben recibir capacitación en la materia.

Formación y Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud y los Pueblos Indígenas:

Las instituciones formadoras de recursos humanos en salud deben poseer capacidad académica, respetar la diversidad cultural, de género y generacional, implementar nuevos paradigmas educativos, que articulen conocimientos ancestrales con herramientas técnicas modernas y, que sobre la base de lo anterior, formen recursos humanos capaces de incidir en la generación de acciones basadas en la confianza y el respeto mutuo.

- ✓ En la formación de pre-grado y de post-grado de los profesionales y técnicos de salud se debe incorporar el enfoque intercultural, estructurándose programas que formen recursos humanos capaces de responder al perfil y necesidades reales de las comunidades indígenas.
- ✓ En lo que respecta a los médicos, mientras se espera que los Centros formadores Universitarios desarrollen programas interculturales en pre-grado, se propone

paliar ésta falencia mediante un proceso de capacitación intensivo, que entregue las herramientas conceptuales necesarias a los profesionales que ejerzan en territorios indígenas, por ejemplo pasantías a experiencias más avanzadas.

- ✓ En la inducción del personal que deba desempeñarse en comunidades indígenas se debe desarrollar un programa de integración del personal recién ingresado que capacite en elementos de la cultura, lenguaje y prácticas de salud de las comunidades.
- ✓ Los programas de formación y capacitación deben incluir no sólo las habilidades técnico- científicas, sino los aportes de las ciencias sociales que incluyan variables antropológicas en su análisis, en el conocimiento de la historia, cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas (formas de vida, valores, organización social, calendario agrícola, calendario de fiestas, organización del tiempo, etc.). Además, deben incluir aspectos de gestión gerencial, liderazgo y comunicación social, para que el trabajador de la salud pueda cumplir a cabalidad sus funciones.
- ✓ El perfil educacional de los técnicos de nivel superior de enfermería y técnicos paramédicos debe responder a las necesidades y realidades de cada zona. Esto significa la refundación del rol del auxiliar rural en tanto ahí confluyen equipo de salud y comunidad. Su formación y capacitación debe estar dirigida al cumplimiento adecuado de las funciones en la comunidad, es decir, incluir aspectos que apoyen su excelencia técnica en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, así como en la promoción de la salud. En aquellos territorios con aislamiento geográfico, deben proveerse las medidas necesarias para contar con un segundo técnico paramédico, que además de tener formación en salud intercultural, sea de origen indígena.

Finalmente la formación de recursos humanos para la salud, la prestación de servicios de salud y la modificación los estilos de vida, no sólo son desarrolladas por los profesionales de salud, sino que es preciso reconocer que hay otros actores como las iglesias y grupos organizados que desarrollan acciones y estrategias para recuperar y promover la salud. Lo anterior debe ser tomado en cuenta e incorporado en la definición de las estrategias de salud.

Estrategias:

- ✓ Promover que los recursos humanos de salud , especialmente en comunas con población originaria, tengan el conocimiento de la cultura, cosmovisión e historia de la comunidad.
- ✓ Incorporar como criterio de selección de los profesionales y técnicos de los establecimientos de salud en comunas con población originaria, el haber aprobado cursos de formación en interculturalidad en salud.

- ✓ Establecer procesos de negociación con las Universidades para la incorporación del enfoque intercultural en salud en las mallas curriculares de las carreras de salud.
- ✓ Establecer incentivos a los recursos humanos que trabajan en territorios indígenas. y que muestran un desempeño satisfactorio en el desarrollo de sus funciones de atención al usuario.
- ✓ Favorecer la formación de profesionales y técnicos indígenas en salud intercultural, con incorporación de docentes provenientes de los pueblos originarios respectivos según territorio y conocedores de la cultura.
- ✓ Incorporar facilitadores interculturales y asesores culturales en la red de servicios. El asesor cultural debe incorporarse como apoyo al trabajo realizado, también en el nivel central, para que el enfoque intercultural esté presente desde la génesis de algunos programas, indicadores y orientaciones ministeriales.

De los facilitadores interculturales.

Los establecimientos de salud de todos los niveles de la red asistencial podrán contar con facilitadores interculturales, si se justifica bajo la solicitud de la comunidad. Ellos deben ser el nexo entre el equipo de salud y las comunidades indígenas, cumpliendo la función de asesores culturales para el equipo de salud. Deben ser personas que pertenezcan a una comunidad indígena y ser avalada por ésta.

Las funciones que deben abordar los facilitadores son:

- a) Orientar, informar y apoyar al enfermo y a sus familiares cuando requieren de atención de salud ambulatoria y de hospitalización.
- b) Coordinar acciones con los diferentes servicios clínicos y administrativos para la resolución del problema de salud.
- c) Apoyar al enfermo y al equipo de salud en resolver situaciones donde lo cultural sea relevante para la recuperación de la salud.
- d) Mantener en forma permanente la relación del paciente hospitalizado con su familia.
- e) Brindar apoyo en las rondas rurales para el seguimiento y resolución de casos clínicos en sus comunidades de origen.
- f) Fomentar la salud en las comunidades.
- g) Realizar visitas domiciliarias en casos indicados por el equipo y/o agentes de salud indígena.
- h) Participación en reuniones atinentes al tema de salud intercultural.
- i) Llevar un registro de las acciones efectuadas.

Perfil:

1. Ser e identificarse como una persona perteneciente a los pueblos originarios
2. Ser bilingüe: lengua originaria y castellano
3. Conocer la cultura y protocolo tradicional de su pueblo y la cultura occidental
4. Mantener contacto con las comunidades y sus organizaciones.

El Facilitador Intercultural debe tener un proceso de capacitación para conocer y manejar la dinámica de funcionamiento del establecimiento de salud y de la red asistencial. Su capacitación debe considerar el manejo del lenguaje, trato al usuario, cultura y organización del sistema de salud y trabajo comunitario. Como también, conocimientos básicos de salud, conceptos de prevención de las enfermedades prevalentes y de promoción de la salud (autocuidado de la salud individual y colectiva).

Los facilitadores deben responder a los requerimientos tanto de parte del equipo de salud como de parte de la propia comunidad.

Los Servicios que cuenten con facilitadores interculturales deben evaluar periódicamente el cumplimiento de sus funciones, especialmente realizar evaluación de desempeño por parte de la comunidad usuaria.

De los Asesores Culturales.

Los Servicios de Salud podrán incorporar asesores culturales en su trabajo con los pueblos originarios. Ellos deben ser personas que pertenezcan a la comunidad y ser validados por esta como representantes de su cultura. Su rol es de coordinación territorial y deben formar parte del equipo técnico que planifica, monitorea y evalúa los planes de salud y pueblos indígenas del Servicio de Salud. En el marco de sus funciones le corresponde interpretar las necesidades, demandas y propuestas que formulan los pueblos originarios a nivel territorial.

Perfil: hablante de la lengua originaria, trayectoria en organizaciones indígenas, habilidades de negociación, liderazgo y compromiso.

10. El Fondo Nacional de Salud y los Pueblos Originarios

El Fondo Nacional de Salud es la instancia encargada de administrar el seguro público de salud. Tiene entre sus más de 9,0 millones de beneficiarios a la gran mayoría de las personas pertenecientes a los pueblos originarios. Algunas de estas personas cotizan para salud, en las Isapres o en FONASA, debido a que son remunerados en forma dependiente o cotizan como independientes. Otros son beneficiarios de FONASA en su categoría de carentes de recursos.

Como todo beneficiario de FONASA, los beneficiarios pertenecientes a pueblos originarios tienen derecho a recibir los beneficios que el Fondo entrega: acceso al Plan de Salud Familiar en el consultorio de su elección; acceso a la red de prestadores públicos para las atenciones secundaria y terciaria; acceso a la red de prestadores públicos para las atenciones secundaria y terciaria; acceso a prestadores privados en convenio bajo la Modalidad Libre Elección y a Subsidios de Incapacidad Laboral, sólo para beneficiarios cotizantes y sus cargas; préstamos de salud; etc.

El Fondo Nacional de Salud como Seguro Público colectivo, solidario y equitativo de salud, debe buscar la forma de ampliar la incorporación de los pueblos indígenas a su universo de beneficiarios, en la línea de avanzar en el cumplimiento de los objetivos propuestos para la salud intercultural.

La participación de los pueblos indígenas en las decisiones que los involucren se constituye en una condición básica, por lo que se debe estimular la participación de representantes de estos grupos específicos en la identificación y resolución de sus problemas.

Estrategias:

De la calidad de atención

- ✓ Implementación de oficinas de reclamos en los sucursales FONASA donde los beneficiarios puedan expresar formalmente y responsablemente su insatisfacción en materia como: demora, mala atención, infraestructura, ubicación, falta de personal, etc.
- ✓ Medición de las evaluaciones positivas de la gestión de las sucursales realizada y en la disminución de los reclamos y quejas por la calidad de atención.
- ✓ Instalación de Sistemas de Tiempos de espera en sucursales.
- ✓ Monitoreo de los estándares tiempos de espera establecidos en aquellas sucursales con el sistema implementado.

De la Infraestructura

- ✓ Implementar nuevas sucursales con sistemas de ordenamiento de acuerdo a la demanda de cada sucursal.
- ✓ Homogeneizar la imagen de cada una de las sucursales que componen la red de distribución, para ello las sucursales deben contar con logo, señalética, etc.
- ✓ Implementar señalética bilingüe en las sucursales que concentra una mayor cantidad de población originaria.

En Recursos Humanos

- ✓ Incorporar funcionarios que hablen la lengua originaria en aquellas sucursales donde acuda una mayor cantidad de población indígena, con el fin de entregar información para facilitar el acceso.

- ✓ Capacitar a nuevos funcionarios en lengua originaria que sea pertinente al territorio.

Estrategias en los mecanismos de aseguramiento de la atención

- ✓ Promover el Plan de Salud en mapudungun y aymara.
- ✓ Facilitar el acceso a los Programas actuales como Programa del Adulto Mayor y Programa de Oportunidad de la Atención.
- ✓ Estudio y definición de criterios para el acceso a la Modalidad Libre elección, con la participación de la CONADI-MINSAL y FONASA.
- ✓ Aumentar la participación de los pueblos originarios en los Comités de Usuarios.
- ✓ Identificar las causales de los puntos críticos, en los cuales existe un déficit de oferta de prestaciones de salud de los pueblos originarios.
- ✓ Crear instancias de participación realizando talleres que permitan intercambiar experiencias.

11. Cooperación y Relaciones Internacionales

En el marco de las relaciones internacionales, los avances alcanzados en relación al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas¹⁸, se establece la necesidad de abordar esta área en la formulación de una política de salud y pueblos indígenas.

La política se refiere entonces a los derechos de los indígenas como pueblos, teniendo como base antes los derechos que como personas poseen, de acuerdo a la Constitución. Se apunta a asegurar la protección y atención de salud para todas las personas en un marco de respeto, consideración y recuperación de su cultura y/u origen, en especial de los pueblos originarios.

Objetivos

En Relaciones Internacionales:

- ✓ Contribuir a la adopción de instrumentos internacionales que protejan los derechos de las personas por realizar, desarrollar y recuperar su cultura en el ámbito sanitario.
- ✓ Promover la incorporación de los acuerdos internacionales en la legislación nacional (ratificación del Convenio N° 169 de la OIT), considerando críticamente los criterios y orientaciones contenidos en ellos, en cuanto reflejan las coincidencias y avances de la comunidad internacional.
- ✓ Representar cabalmente la posición ministerial en los foros sanitarios internacionales que se aborde la materia.
- ✓ Proyectar la perspectiva sectorial hacia la formulación de política exterior y de instrumentos internacionales.

¹⁸ Los instrumentos internacionales de reconocimiento de estos derechos se presentan en la tercera parte del documento: Antecedentes.

- ✓ Participar y apoyar la Iniciativa Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas (SAPIA) de OPS/OMS.

En cooperación internacional:

- ✓ Nutrir el proceso de formulación de políticas y programas, con el conocimiento y experiencias de otros países (en especial de América Latina); para ello debe desarrollarse un conocimiento actualizado en esta materia¹⁹, ocupando distintas modalidades de trabajo.
- ✓ Proporcionar cooperación técnica basada en la experiencia del sistema de salud chileno a solicitud de otros países de América Latina.
- ✓ Promover formas de cooperación especiales en zonas fronterizas (Perú - Bolivia - Argentina).
- ✓ Promover y asesorar técnicamente la cooperación entre pueblos indígenas.
- ✓ Formular proyectos de cooperación para consideración de gobiernos y organizaciones internacionales (países, OPS/OMS, Unión Europea, otros).

Temas de Cooperación

Los temas de trabajo surgirán de las exploraciones bilaterales y multilaterales, luego de la identificación de las capacidades propias de cada país en la materia. Son prioritarias las áreas de:

- ✓ Desarrollo de recursos humanos: prácticas tradicionales de apoyo, desarrollo de la perspectiva multicultural.
- ✓ Mecanismos de participación y negociación social.
- ✓ Relación medicina oficial y medicina tradicional.

Algunas oportunidades específicas de cooperación: Fondo Voluntario de Naciones Unidas para el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, Iniciativa SAPIA y Cooperación horizontal con América Latina.

12. Investigación

Epidemiología Sociocultural

Para el desarrollo de este enfoque, se deben realizar estudios de situación de salud bajo la mirada de una epidemiología socio cultural que tome en cuenta las propias categorías de salud enfermedad de los pueblos originarios, factores protectores y factores de riesgo desde su propia cultura.

¹⁹ Revisión regular de fuentes de información secundaria/terciaria sobre otros países y organismos internacionales (Páginas Web, Publicaciones, etc.)

Es así como los perfiles de mortalidad y morbilidad son un eje articulador esencial en estos procesos, los que con esta nueva mirada son colocados dentro de un ámbito territorial, destacando la importancia de las comunidades como grupos humanos delimitados socio - culturalmente. Este eje articulador esencial, debe ser valorado no sólo por el equipo de salud como orientador de acciones, sino también por las propias comunidades, en las cuales las dimensiones espirituales, socio – culturales, políticas o económicas, cobran una importancia más integral que la que el sector Salud le ha otorgado tradicionalmente. Esto permitirá desarrollar un perfil más completo donde se enriquece la trama de condicionantes y determinantes de las formas de enfermar y/o morir de los pueblos originarios.

Para el desarrollo de este enfoque, se plantea la realización de estudios de situación de salud bajo la mirada de una epidemiología sociocultural que tome en cuenta las propias categorías tanto de problemas de salud de los pueblos originarios, como de sus propuestas de intervención o de solución. Esto permitiría la construcción de un perfil con indicadores pertinentes lo que podría llevar a desarrollar planes de acción que enfrenten los determinantes sociales y deben ser gestionados con integralidad.

Consideraciones:

La realización de estudios e investigaciones en temas de salud y pueblos indígenas, debe enmarcarse en las siguientes orientaciones y principios²⁰:

- ✓ Propender la conformación de equipos de investigación multidisciplinarios e interétnicos, en los territorios de los Servicios de Salud, en pos de la producción conjunta de conocimientos, incorporando la participación indígena en los estudios de salud que se efectúen, la que deberá aprobar los estudios y su enfoque. Proponer guías o protocolos para la participación indígena en las investigaciones de salud.
- ✓ Incorporar la visión de los pueblos originarios en los enfoques de la investigación que se desarrollen por parte de los equipos de salud.
- ✓ Incentivar el desarrollo de enfoques participativos en las investigaciones, en los que se incorpore la definición conjunta de categorías de investigación.
- ✓ Considerar en las investigaciones los factores históricos, sociales y culturales. Favorecer la entrega de herramientas metodológicas a las comunidades, para el desarrollo de herramientas propias.
- ✓ Incorporar en los proyectos de investigación la evaluación del impacto ambiental en la salud y en cultura de los pueblos indígenas.
- ✓ Considerar en las propuestas de investigación un enfoque integral, evitando los enfoques aislados de la cultura indígena y del hábitat, por ejemplo estudios de plantas medicinales fuera del contexto cultural.

²⁰ Gran parte de las recomendaciones se señalan en “Hacia el abordaje integral de la salud: Pautas para la investigación con pueblos indígenas” OPS/OMS, 1996.

- ✓ Promover el establecimiento oficial de los derechos de propiedad intelectual y los beneficios obtenidos de la investigación.
- ✓ Promover la reflexión y el intercambio de experiencias de investigación en espacios interculturales.
- ✓ Difundir el documento producto del grupo de trabajo a las diferentes organizaciones indígenas, reconociendo su participación explícitamente y devolver a la comunidad sus resultados.

II PARTE: MARCO POLÍTICO Y LEGAL

La construcción de una política de Salud y Pueblos Indígenas en Chile se sustenta en variados antecedentes, tanto en el contexto de procesos nacionales e internacionales de movilización de los pueblos indígenas, como de la legislación y acuerdos internacionales sobre el reconocimiento y derechos de los pueblos indígenas, y también en el marco de la generación de políticas estatales, a nivel nacional, en diversos ámbitos de desarrollo.

a) Antecedentes históricos

Es de interés señalar que desde la Independencia de España, en general la política indigenista de los países americanos fue liberal e integracionista en lo político cultural, pretendiendo la integración de los grupos originarios a la sociedad dominante. En nuestro país, los continuos conflictos por propiedad de la tierra respecto a las políticas colonizadoras, que aconsejaban la conveniencia de un arbitraje, llevaron a la restitución de la figura colonial del “protector de indígenas” (1852), y más tarde, a la creación de los juzgados de indígenas (1930).

La necesidad de considerar más específicamente los factores culturales, por ende un primer atisbo de consideración favorable hacia la identidad de los pueblos originarios, surge en la creación del Instituto Indigenista Interamericano (I.I.I., Pátzcuaro, México, 1940). En esta ocasión, Chile estuvo representado por el carismático líder mapuche Venancio Coñuepán; posteriormente el primer encargado de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Agricultura (1953). Sin embargo, en general las preocupaciones mayores giraron acerca de la propiedad y productividad de la tierra.

Todos los países de la región adoptaron políticas indigenistas análogas, en base a un ente estatal autónomo, que desarrolla diferentes políticas de desarrollo comunitario hacia los pueblos originarios que continúan viviendo en calidad de tales.

A mediados de los años ochenta, el Instituto Indigenista Interamericano realizó un Convenio con la OPS, mediante la cuál ésta se transforma en una especie de agencia de apoyo sanitario para las políticas que impulsa en estas materias.

En Chile, la preocupación por la identidad cultural, ampliando al menos teóricamente la perspectiva anterior, surge con la Ley N° 17.729, de 1972, que creó el Instituto de Desarrollo Indígena, de escasa existencia al devenir luego el gobierno militar. Esta iniciativa fue reiterada por la Ley N° 19.253, de 1993, que creó la CONADI. Ambas legislaciones basan esta acción en la creación de un organismo técnico autónomo.

b) Instrumentos internacionales vigentes

Son numerosos los instrumentos internacionales que abordan directamente o indirectamente el tema de los pueblos indígenas. Entre ellos, cabe destacar como hitos esenciales, dada su integralidad y las implicancias que tiene para el sector salud, las siguientes:

- ♦ Convenio OIT N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989).
- ♦ Designación del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 1995-2004 (Resolución ONU N° 48/163 de 1993).
- ♦ Resolución V OPS/OMS sobre "Salud de los Pueblos Indígenas en las Américas" (SAPIA), que a su vez se basa en la Reunión de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Salud, realizada en Winnipeg, Canadá, 13-17 Abril 1993.
- ♦ Designación del Segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 2005-2015 (ONU 59 Asamblea General que se inicia el 1 de enero 2005)

c) Antecedentes: hitos previos importantes

Hasta la adopción del Convenio N° 169 de la OIT, no había instrumentos internacionales que reconocieran explícitamente los derechos indígenas: ni la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ni el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales mencionan éstos en forma específica, sin embargo, es evidente que han representado la base para la elaboración de los mismos.

En los años 40, tales derechos eran visualizados como problemas de "minorías étnicas": el Art. 27 del Pacto de Derechos Civiles señala que: "En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a ellas, el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y emplear su propio idioma". Ese artículo es la primera mención del tema en el marco internacional de protección de los derechos de las personas, por cuanto: (1) reconoce con claridad la existencia de grupos colectivos diferenciados del resto de la sociedad, (2) señala claramente que esos derechos se ejercen en común y no en forma individual y, (3) se otorga el ejercicio del "derecho que les corresponde", esto es, un derecho anterior a las declaraciones, pactos y leyes.

Entre los 70-80 se comenzó también a discutir el tema de los derechos colectivos, a través del cual se busca proteger y desarrollar las propias y particulares características culturales de una colectividad. En torno a esto surgieron nuevos conceptos; el de "territorio" por ejemplo, que se refiere a un concepto más

abstracto que el de “tierras”, y es el conjunto físico y simbólico en el que habita un pueblo con su patrimonio cultural.

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU nombró al experto Martínez Cobo para realizar un estudio acerca de las poblaciones indígenas y llegar a una definición de las mismas. Éste propuso una definición de trabajo que remarcaba una diferencia entre minorías o grupos minoritarios en general y poblaciones indígenas (no utilizaba el término “pueblos”), en que estas últimas existían como consecuencia de un proceso histórico de conquista y colonización impuesta por una cultura transoceánica.

d) Designación del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 1995 - 2004 (Resolución ONU N° 48/163 de 1993).

Las Naciones Unidas iniciaron su primer trabajo formal sobre poblaciones indígenas en 1982, con el establecimiento del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (Res. 2/34 de 1982). Desde entonces, se han realizado una amplia gama de actividades como parte del programa de derechos humanos de la Organización y dentro del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto.

Probablemente el logro más importante hasta ahora ha sido la elaboración, por parte del Grupo de Trabajo, del proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El proyecto se terminó de elaborar en 1993, tras diez años de trabajo, con la participación de muchos Gobiernos y cientos de organizaciones indígenas. El proyecto fue presentado en 1994 por el Grupo de Trabajo a la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección de las Minorías, la cual lo adoptó y presentó a la Comisión de Derechos Humanos en 1995. La Comisión ha establecido el Grupo de Trabajo de composición abierta sobre el proyecto de declaración para revisar el texto presentado por la Subcomisión.

Allí, el debate ha estado concentrado en el reconocimiento de los derechos colectivos y el significado e implicancias del concepto “libre determinación”, su aspecto más controvertido. El objetivo es concordar y aprobar un instrumento de carácter vinculante, esto es, que obligue a los Estados. En el derecho internacional, las declaraciones no tienen la misma fuerza vinculante que las convenciones, pactos y, por sobre todo, los tratados; pero son uno de los instrumentos que permiten la operación de los sistemas internacionales de protección. Los Estados aprueban las declaraciones en la Asamblea General de Naciones Unidas y posteriormente deben ratificarla individualmente.

La Asamblea General proclamó 1993, el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y, dos años más tarde, decidió celebrar el período 1995-2004 como el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo e hizo una llamada a todos los Estados, al sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales para que contribuyesen a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones indígenas bajo el lema "Poblaciones indígenas: colaboración en acción". El Decenio tiene como coordinadora a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas es también una iniciativa enmarcada en el Decenio. Está concebida para dar adecuada atención y consideración a escala internacional, a las materias y problemas que interesan a los pueblos indígenas, en función esencialmente de sus particularidades. El Grupo de Trabajo no ha alcanzado consenso aún sobre esta iniciativa, habiéndose celebrado ya dos seminarios sobre el tema: Copenhagen en junio de 1995 y otro en Santiago de Chile, en junio de 1997.

La meta del Decenio es fortalecer la cooperación internacional a fin de solucionar los problemas con que se enfrentan los indígenas en el ámbito de los derechos humanos, la cultura, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. Uno de sus principales objetivos es la aprobación de una Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la formulación ulterior de normas internacionales, así como promover la aplicación de las recomendaciones relativas a las poblaciones indígenas, formuladas en todas las conferencias internacionales.

e) El Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. OIT, 1989

Surge como resultado de la revisión de normas anteriores de la OIT, en especial el Convenio 107 de 1957, sobre "poblaciones indígenas y tribales". Fue adoptado por la Conferencia General con fecha 7 de junio de 1989, siendo el primer instrumento que se refiere a "pueblos indígenas". Aunque el primero contiene un riguroso elemento de protección fue revisado porque sus disposiciones se consideraron obsoletas debido a su enfoque de corte integracionista. No obstante, sigue vigente en 20 países y, a menudo, es el único elemento de protección internacional del que se dispone. La perspectiva integral sobre los pueblos indígenas que tiene este Convenio, al abordar una gran amplitud de aspectos manifiesta su creciente reconocimiento internacional.

El Convenio 169 ha sido ratificado por 13 países: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Fiji, Guatemala, Honduras, México, Noruega, Países Bajos,

Paraguay y Perú. El proceso de ratificación ha sido lento, siendo probable que constituya un documento avanzado para las políticas de varios países. La ratificación del Convenio implica un reconocimiento amplio de los pueblos indígenas, por parte de los gobiernos firmantes, basado en los conceptos de respeto y participación, considerando la conciencia de "identidad indígena o tribal, como criterio fundamental para determinar los grupos interesados". En su texto, el término 'pueblo' responde a la idea de que tienen "identidad y organización propia".

No obstante, un inciso agregado cercena su derecho a la libre determinación al establecer que el uso del término 'pueblos' en el Convenio "no deberá interpretarse en el sentido que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que puedan conferirse al dicho término en el Derecho Internacional".

En el sentido anterior, el Convenio hace explícito el temor de la comunidad internacional de reconocer derechos especiales a los indígenas, en cuanto a que la libre determinación conduzca a demandas separatistas de gobernabilidad.

El debate en Chile ha estado también marcado por esos mismos aspectos, lo que condujo a su congelamiento y posterior retiro del Parlamento, donde había ingresado con fecha 3/enero/1991, pasando las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y de Relaciones Exteriores. Esta última solicitó la opinión de un grupo de constitucionalistas, los que, con la excepción del Profesor Alejandro Silva Bascuñán, señalaron que en la Constitución la idea de 'pueblo' era unívoca, o sea, se hablaba de "un solo pueblo: la nación chilena". El citado Profesor indicaba que era constitucional y no se oponía a ella, porque podía comprenderse a los pueblos indígenas como cuerpos intermedios de la sociedad, reconocidos y valorados constitucionalmente. Esta posición fue minoritaria y condujo a su no-aprobación, como también al retiro de la Reforma que introducía el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en 1992. El proyecto de acuerdo volvió a ingresar al Senado con fecha 12/04/2000, siendo tratado en varias sesiones, hasta que en la Sesión 25° (23/01/2001) se retira la suma urgencia.

Los aspectos esenciales de la discusión en el nivel nacional, quedan reflejados en el Proyecto de Declaración que aprueba el Convenio, elaborado por Cancillería, que reza:

"El Gobierno de la República de Chile, al momento de proceder a la ratificación del Convenio ... , declara, a los efectos de su aplicación en Chile: que el reconocimiento de los derechos previstos en el mismo, tiene por objeto, no sólo garantizar en la práctica su igualdad entre los miembros de la comunidad nacional,

sino que también la efectiva integración a ésta de los individuos de los referidos pueblos, en términos de igualdad y respetando sus peculiaridades culturales; que tal reconocimiento no puede implicar el otorgamiento a esos pueblos de la calidad de sujeto de derecho internacional; que el ejercicio de los aludidos derechos no puede constituir privilegios, ni afectar los derechos de los demás miembros de la comunidad nacional, o a la integridad territorial de la República; que, por todo lo anterior, los habilitados para ejercer los mencionados derechos ..., son sólo los individuos de dichos pueblos y no éstos; y, que la Ley (Indígena) tiene por objeto precisamente resguardar los derechos de los indígenas, de manera que mediante dicho cuerpo legal se está dando cumplimiento a los objetivos que persigue el Convenio."

Esta declaración involucra lo relativo al régimen de salud de las personas, en tanto el reconocimiento de derechos especiales no puede afectar los derechos de los demás habitantes en este campo y que se refiere a los individuos de esos pueblos y no a los pueblos como sujeto de derecho.

Contenido del Convenio: El Convenio se aplica a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional en virtud de su ascendencia. Los gobiernos de los Estados que lo ratifican deben asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

Indica que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos de los pueblos indígenas; que deberán consultar a los pueblos interesados las medidas que puedan afectarles y establecer los medios de participación; reconoce la relación especial indígenas – tierras/territorios que ocupan o utilizan; estipula que no deben ser trasladados y que cuando excepcionalmente sea necesario, deberá efectuarse con su consentimiento.

Aprobó además una resolución que establece medidas a tomar en los niveles nacional e internacional, para apoyar su cumplimiento.

El articulado considera:

- ❖ Política general
- ❖ Tierras
- ❖ Contratación y condiciones de empleo
- ❖ Formación profesional, artesanía e industrias rurales

❖ Seguridad social y salud (Art. 24-25)

- Plantea una extensión progresiva y sin discriminación de los regímenes de seguridad social a los pueblos interesados (Art.24)
- Velar por servicios de salud adecuados o proporcionar a esos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios.
- Organizar servicios de salud a nivel comunitario, en lo posible, que deben planearse y administrarse en cooperación.
- Los servicios deben tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
- Preferencia a la formación y empleo de personal de salud local.
- Coordinación con las demás medidas sociales, económicas y culturales.

❖ Educación y medios de comunicación

❖ Contactos y cooperación a través de las fronteras

f) Resolución V OPS/OMS "Salud de los Pueblos Indígenas en las Américas"

Originada a partir de las recomendaciones de la Reunión de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, celebrada en Winnipeg, Canadá con fecha 13-17 de abril de 1993.

Apunta hacia la incorporación de los problemas de salud de los pueblos indígenas en las políticas y programas de la OPS/OMS.

Orientada a "...recuperar y utilizar las... lecciones del saber autóctono, que pueden y deben complementar el saber de la ciencia y tecnología moderna".

Formula la Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas de las América (SAPIA), sobre la base de los principios acordados en Winnipeg:

- La necesidad de un abordaje integral de la salud
- El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas
- El derecho a la participación sistemática
- El respeto y la revitalización de las culturas indígenas
- La reciprocidad en las relaciones

Sus lineamientos generales son:

- Promoción de la salud
- Transformación del sistema de salud: equidad, acceso, descentralización y participación social.
- Plan de inversiones en ambiente y salud
- Recursos humanos
- Evaluación y vigilancia de la salud y condiciones de vida

- Formulación de políticas, aspectos legales y éticos.

g) Segundo Decenio internacional para los Pueblos Indígenas del mundo

El 20 de diciembre 2004 la 59 Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Segundo Decenio 2005-2015 que se inicia el 1 de enero 2005

La quincuagésimo novena Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 2005-2015, el mismo que se inicia este primero de enero.

La decisión pone énfasis en fortalecer la cooperación internacional para la solución de problemas que enfrentan los pueblos y personas indígenas en áreas tales como la cultura, la educación, la salud, los derechos humanos, el ambiente y desarrollo social y económico.

Cabe destacar que la proclamación de un Segundo Decenio ha sido una petición expresada de manera insistente por el movimiento indígena internacional en diversos foros internacionales ante la constatación de que una de las principales acciones contempladas en el Plan de Acción del primer Decenio –la aprobación del Proyecto de Declaración ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas - no iba a ser cumplida.

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, un importante organismo subsidiario del Consejo Económico Social (ECOSOC), aprobó en mayo de 2003 la recomendación de adoptar un segundo Decenio.

h) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Este instrumento internacional fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965. Entró en vigor en 1969, siendo ratificada por Chile en 1971, y publicada en el Diario Oficial el 12 de noviembre de 1971.

El art. 1.1 señala que la expresión “Discriminación racial” denotará “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

Esta Convención aclara (art. 1.4 y art. 2.2) que las medidas especiales que los Estados adopten con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran protección necesaria o para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de dichos grupos no se

considerarán discriminatorias siempre que no conduzcan al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales, y que no se mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. De este modo, se da base para las medidas de acción afirmativa o “discriminación positiva”.

De acuerdo con el art. 3 los Estados Partes condenan especialmente la segregación racial y el *apartheid* y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar de sus respectivos territorios las prácticas de discriminación racial en todas sus formas.

Desde su aprobación, se han realizado varias Conferencias Mundiales para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial, y se han declarado tres Decenios de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial.

Una parte del Programa de Acción para el Segundo Decenio se centró en la eliminación del *apartheid*. Otras medidas comprendían la promoción y protección de los derechos humanos de personas pertenecientes a grupos minoritarios, de poblaciones indígenas y trabajadores migrantes; y la creación de procedimientos de interposición de recursos para las víctimas de la discriminación racial. El Programa de Acción incluía una campaña de información pública a escala mundial en favor de los derechos humanos y la redacción, por la Comisión de Derechos Humanos, de un “modelo nacional de legislación” para orientar a los gobiernos en la promulgación de leyes contra la discriminación racial.

El 20 de diciembre de 1993 la Asamblea General proclamó el Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, (1994 a 2003). También en 1993, la Comisión de Derechos Humanos designó a un Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. El Tercer Decenio abarca una visión ampliada del racismo, incluida la comprensión de que todas las sociedades del mundo se ven afectadas y obstaculizadas por la discriminación. El Programa de Acción para el Tercer Decenio destaca el papel fundamental de la educación para garantizar el respeto de los derechos humanos.

La comunidad internacional se ha propuesto examinar las raíces básicas del racismo y solicitar los cambios requeridos para prevenir el estallido de conflictos generados por el racismo y la discriminación racial. Objeto obligado de examen han sido la llamada “depuración étnica”, el genocidio y la institucionalización de la xenofobia. Se ha visto, en este marco, que la globalización abre nuevos escenarios que obligan a idear nuevos enfoques y métodos para renovar el compromiso de lucha contra el racismo y la discriminación racial.

Referencias Bibliográficas

1. Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de Desarrollo Sostenible. Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario. **"Etnoingeniería. Marco Conceptual."** Carlos Preafán. Washington D.C., Mayo del 2001.
2. CEPAL. **"Discriminación Étnico Racial y Xenofobia en América Latina y el Caribe"**. Martín Hopenhayn y Alvaro Bello. División de Desarrollo Social, serie de Políticas Sociales N° 47, Santiago de Chile, Mayo 2001.
3. Castro, Mario. **"Salud Colectiva y Medio Ambiente"**. Unidad de Salud con Población Mapuche, Servicio de Salud Araucanía Sur, Ministerio de Salud, 2003.
4. Ley 19.253 **"Protección, Fomento y Desarrollo Indígena"**. Chile, 1993.
5. Marsall M. T.; Sáez, M. y Salinas, J. **"Participación en Salud: Lecciones y Desafíos"**. CORSAPS, Santiago, Chile, Mayo, 1991.
6. Ministerio de Planificación y Cooperación – Ministerio de Salud. **"Primer Seminario Nacional de Salud Intercultural y Políticas Públicas"**. Santiago de Chile, 21 y 22 de Octubre de 1999.
7. Ministerio de Planificación y Cooperación. **"Informe Final Grupo de Trabajo para los Pueblos Indígenas."** Palacio de la Moneda, Mayo del 2000.
8. Ministerio de Salud – División de Salud de las Personas **"Marco de referencia para la acción regional en Promoción de Salud"**. Documento de Trabajo, mayo, 1997.
9. Ministerio de Salud – Servicios de Salud Araucanía Sur **"Taller Nacional Salud y Pueblos indígenas. Salud, Cultura y Territorio: bases para una epidemiología intercultural"**, Likanray – Brotes de Luna Nueva, Región de la Araucanía, Chile, 1998.
10. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. **"Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas D.N.S.P.I"** Septiembre 2000.
11. Ministerio de Salud, **"Objetivos sanitarios y modelo de salud para la década 2000-2010"**, Enero 2002.
12. Ministerio de Salud. **Modelo de Atención con Enfoque Familiar en el Nivel Primario**. División Atención Primaria, Depto. Modelo de Atención, Enero, 2002.
13. Ministerio de Salud. **"Hacia un Nuevo Modelo de Gestión en Salud"** Contenidos del Proyecto de Ley de Autoridad Sanitaria y Gestión en Salud y de Medidas Administrativas Inmediatas. Junio 2002.
14. Ministerio de Salud, **"Plan Nacional de Promoción de la Salud" 1998 – 2000**.
15. Ministerio de Salud. **"Ley de Autoridad Sanitaria"** N° 2763, 2004.
16. Ministerio de Salud. **"Atención de Salud con enfoque Familiar"**. División Atención Primaria, Depto. Modelo de Atención, Enero, 2002.

17. Ministerio de Salud, Departamento de Epidemiología. **“Años de Vida Potenciales Perdidos según comunas . Chile, quinquenio 1994-1998”**. En: http://epi.minsal.cl/estudios/avpp_por_comuna_199498.htm
18. Ministerio de Salud, División de Salud Ambiental: **“Estimaciones de Población Indígena en riesgo de Salud por Condiciones de Saneamiento Ambiental”**. Documento de trabajo, 2001.
19. Ministerio de Salud. Departamento de Epidemiología. González C., Aguilera X., Guerrero A. , Child V., Georg V. “Indicadores comunales para el estudio de la desigualdad en salud”, en: **“Situación de Salud Chile 2000”**. Compilación de documentos, Enero 2001. En: <http://epi.minsal.cl>
20. Ministerio de Salud. División de Atención Primaria. Unidad de Promoción de la Salud. **“Promoción de la Salud para Chile. Plan Nacional de Promoción de la Salud”**. Santiago, 1999.
21. Ministerio Secretaría General de Gobierno. División de Organizaciones Sociales. **“Bases generales del Plan Nacional para superar la discriminación en Chile 2001-2006”**. División de Organizaciones Sociales, 2001.
22. Naciones Unidas. **“Segundo Decenio para los Pueblos Indígenas del Mundo”**. En Actualidad indígena Año 1 N° 44-27 de diciembre de 2004 – Servicio de Información Indígena SERVINDI
23. Organización Internacional del Trabajo. OIT **“Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales”**. En: <http://www.oit.org/public/spanish/index.htm>
24. Organización Panamericana de la Salud – Ministerio de Salud. **“Encuentro Internacional Salud y Pueblos indígenas. Logros y desafíos en la Región de las Américas”** . Puerto Varas, Región de Los Lagos, Chile, 13, 14 y 15 de Noviembre de 2000.
25. Organización Panamericana de la Salud – Programa de Políticas Públicas y Salud – División de Salud y Desarrollo Humano. **“Equidad en Salud desde la perspectiva de la etnicidad”**. Washington D.C., Junio 2001.
26. Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS **“Fortalecimiento y desarrollo de los sistemas de salud tradicionales: Organización y provisión de servicios de salud en poblaciones multiculturales”**. Serie Salud de los Pueblos Indígenas. División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud. Washington, D.C. Mayo, 1997.
27. Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS **“Iniciativa de los Pueblos Indígenas: Informe de Progreso”**. Serie Salud de los Pueblos Indígenas. División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud. Washington, D.C. Mayo, 1998.
28. Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS **“Orientación de los Marcos Jurídicos hacia la Abogacía en Salud de los Pueblos Indígenas”**. Serie Salud de los Pueblos Indígenas. División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud. Washington, D.C. Mayo, 1998.

29. Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS **Resolución V "Salud de los Pueblos Indígenas en las Américas". HSS/SILOS-34 Serie Desarrollo y Fortalecimiento de los sistemas locales de salud, 1993.** En <http://www.paho.org>
30. Oyarce, Ana María. **"Sistematización sobre los avances del proyecto Enfoque de Salud con Población Mapuche"**. Documento de Trabajo. Servicio Salud Araucanía, 1996.
31. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) **"Informe Desarrollo Humano en Chile - Año 2000"**. En: <http://www.desarrollohumano.cl/indice.htm>
32. Sáez, Margarita. **"Demandas y Necesidades en la Utilización de Servicios de Salud de Atención Primaria por parte de Población Mapuche residente en dos comunas de la Región Metropolitana"**. Tesis Magíster en Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, 2003.
33. Servicio de Salud Araucanía Sur – Programa de Salud con Población Mapuche – Asociación de Municipalidades Región de la Araucanía – Ministerio de Salud – Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. **"Tercer Encuentro Nacional de Salud y Pueblos Indígenas. Sistematización de experiencias de trabajo intercultural en salud"**. Villarrica, 10, 11 y 12 de noviembre de 1999.
34. Servicio de Salud Araucanía Sur – Unidad de Salud con Población Mapuche. Equipo Mapuche de cogestión en salud. **"Propuesta para una Política de salud en territorios mapuche"**. 21 y 22 de septiembre 2001.
35. Toledo Llancaqueo, V. **"Situación de Salud de los Pueblos Indígenas de Chile"**. Documento de Trabajo. OPS/MINSAL Chile, 1997.
36. Unidad de Salud con Población Mapuche, Servicio de Salud Araucanía y Unidad de Salud y Pueblos Indígenas, Ministerio de Salud. **"Memoria Primer Encuentro Nacional Salud y Pueblos Indígenas: Hacia una Política Nacional Intercultural en Salud"**. Saavedra, Región de la Araucanía, Noviembre de 1996.
37. Valdés, Marco : **"Instrumentos De Cuantificación de Población Indígena: El Censo de Población y Vivienda 1992 y Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional Casen 1996."** En: <http://www.soc.uu.se/mapuche/mapuint/valdes9901.htm>
38. Valenzuela Fernández, R. **"Situación de los Pueblos Indígenas en Chile. Análisis de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen 1996)"**.
39. Mideplan, Apuntes de Trabajo Documento N°1, Enero 1998. En: <http://www.soc.uu.se/mapuche/mapuint/valen990500.htm> Verdugo, Juan Carlos et al. **"Hacia un Primer Nivel de Atención en Salud Incluyente: bases y lineamientos"**. Instancia Nacional de Salud, Guatemala, 2002.

